

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026



RED DE SALUD CELENDIN



Firmado digitalmente por JULCA ROJAS
Melchora FAU 20165645325 soft
DIRESA - RED CELENDIN - Directora
Motivo: Firmo en señal de conformidad
Fecha: 17/08/2026 10:36 a. m.

PRESENTACION.....	4
I. CONDUCCION ESTRATEGICA	7
1. Visión y Misión DIRESA Cajamarca	7
2. Visión y Misión de la Red de Salud Celendín.....	7
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	8
1. Órgano.....	8
2. De Dirección	8
3. Órgano De Apoyo	8
5. Órganos de Línea.....	8
6. Órganos Desconcentrados	8
III. ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD	10
1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.....	10
1.1. Ubicación y limites.....	10
1.2. Superficie y división política	11
1.3. Accesibilidad	12
2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS	13
2.1. Indicadores de Dinámica Poblacional a nivel regional	13
2.2. Composición y estructura de la población	14
2.2.1. Población provincial por curso de vida y sexo	14
2.2.2. Pirámide poblacional.....	16
2.2.3. Población por provincia y distritos de Celendín, por curso de vida.....	17
2.2.4. Población afiliada al SIS Provincia de Celendín	18
2.2.5. Población afiliada al SIS por distrito 2023 al 2025	19
3. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES	20
3.1. Determinantes socioeconómicos	20
3.1.1. Pobreza	20
3.1.2. Educación	21
3.1.3. Desempleo	22
3.1.4. Dependencia económica.....	23
3.1.5. Densidad del estado.....	24
3.2. Circunstancias materiales.....	25
3.2.1. Viviendas con acceso a agua potable.....	25
3.2.2. Viviendas con acceso a desagüe	26
3.2.3. Hacinamiento	27
3.2.4. Hogares que cocinan con leña y/o estiércol	28
3.3. Factores Psicosociales	29

3.3.1.	Migración	29
3.4.	Sistemas de Salud	30
3.4.1.	Establecimientos de la Red de Salud Celenadin	30
3.4.2.	Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas y Esenciales (FONE)	32
3.4.3.	Referencias y Contrarreferencias:	33
3.4.4.	Recursos Humanos	40
3.4.5.	Equipamiento	41
3.4.6.	Infraestructura	44
3.4.7.	Medicamentos	45
3.4.8.	Residuos sólidos.	46
3.4.9.	Sistema de Información	49
4.	ANÁLISIS DE ESTADO DE SALUD	50
4.1.	Morbilidad	50
4.2.	Mortalidad	52
4.3.	Vigilancia Epidemiológica.	54
4.3.1.	VIH	54
4.3.2.	TUBERCULOSIS	55
4.3.3.	LEISHMANIASIS	55
4.3.4.	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)	56
4.3.5.	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)	56
4.3.6.	CÁNCER	57
4.3.7.	DIABETES MELLITUS	57
4.3.8.	ANEMIA	58
4.3.9.	DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL (DCI)	60
4.3.10.	DIABETES	63
4.3.11.	HIPERTENSIÓN	65
4.3.12.	PRIORIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	67

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión desarrollado bajo el enfoque por resultados, está orientado a la planificación para el logro y medición de resultados e impacto en salud, así mismo busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, a fin de contribuir en la mejora del desempeño del estado respecto al bienestar de la población.

El presente documento establece las principales actividades que desarrollarán la Red de Servicios de Salud Celendín, a través de sus coordinaciones, Microrredes e Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPRESS) en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Dirección Regional de Salud Cajamarca, orientadas a garantizar el acceso oportuno, continuo, integral y de calidad a los servicios de salud de la población, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación.

Teniendo en consideración que es necesario contar con un documento que articule a cada uno de los actores sociales (JUNTOS, CUNA MÁS, QALIWARMA, PENSIÓN 65, entre otros) involucrados en la salud pública de nuestro ámbito territorial, se espera que el presente Plan Operativo Institucional, logre concretizar nuestra misión y el fin de los servicios de salud obteniendo como resultado final la mejora de la salud individual y familiar de la población Celendín.

La formulación del POI considera las necesidades sanitarias de la población, las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud Cajamarca, así como las capacidades institucionales y disponibilidad de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.



Firmado digitalmente por JULCA
ROJAS Melchora FAU
20165645325 soft
DIRESA - RED CELENDIN -
Directora
Motivo: Visto en señal de
conformidad
Fecha: 17/08/2026 10:45 a. m.

LIC. ENF. MELCHORA JULCA ROJAS
DIRECTORA DE LA RED DE SALUD CELENDÍN

LIC. PSIC. YHARITA CATALINA, HUAMAN COSME
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

C.P.C. LUIS OSCAR LLANOS MOSQUEIRA
COORDINADOR DE PLANEAMIENTO Y LOGISTICA

C.P.C. HILDA SOLEDAD TAMAYO RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

OBSTA. YAYITA DEL CARMEN CASTILLO CABRERA
COORDINADORA ATENCION INTEGRAL DE SALUD, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, CÁNCER DE
CUELLO UTERINO Y CURSO DE VIDA MATERNO PRENATAL

PROF. MIGUEL ANGEL SALAZAR VEGA
COORDINADOR DE OITE

LIC. ENF. ROSA MARIA ASTO VARGAS
COORDINADORA DE SERVICIOS DE LA SALUD, OFERTA MOVIL, RIS, INTERCAMBIO
PRESTACIONAL, TELESALUD, SUPERVISIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS,
CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION, EQUIPAMIENTO, CLAS, GESTION HOSPITALARIA,
CARTERA DE SERVICIOS, REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS U SALUD OCUPACIONAL

LIC. ENF. ROINER HUAMÁN ALTAMIRANO
COORDINADOR DE EPIDEMIOLOGIA, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METAXENICAS Y
ZOOTICAS, CADENA DE FRIO Y ENFERMEDADES DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES

LIC. PSIC. MARCO ANTONIO GUTIERREZ VELASQUEZ
COORDINADOR DE UNIDAD DE SEGUROS, SALUD MENTAL, CURSO DE VIDA ADOLESCENTE,
CURSO DE VIDA JOVEN, CURSO DE VIDA ADULTO, CURSO DE VIDA ADULTO MAYOR

LIC. ENF. EYDI ENITH MORI TRIGOSO
COORDINADORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, SALUD FAMILIAR, SALUD ESCOLAR Y GESTION
DE LA CALIDAD

LIC. ENF. LEIVA ROJAS,
CORDINADORA DE SALUD AMBIENTAL

Q.F. MARLENI ELIZABETH BARDALES BRIONES
COORDINADORA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

ING. MAYTA INFANTE, SILVIA ESMERALDA
PATRIMONIO, EMERGENCIAS Y DESASTRES Y ONIESS

Q.F. CARMEN URIARTE MUÑOZ
COORDINADORA DE LABORATORIA Y PRONAHEBAS

LIC. ENF. ALEJANDRA ROSSMERY LLONTO FIGUEROA
COORDINADORA CURSO DE VIDA NIÑO, ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES,
ESTRATEGIAS SANITARIAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Y METALES PESADOS

OBSTA. ANA BELEN RAMOS SALDAÑA
ITS, VIH - SIDA / TBC / PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES

TEC. CONT. SANTOS ANGELICA REYES MONZON
COMPENSACIONES, ONE VISIÓN - RR.HH Y COMUNICACIONES

TEC. FARMACIA DANY SOCORRO SOLANO MEDINA
RESPONSABLE DE TESORERÍA

JORGE MILTHON GOYCOCHEA SOLANO
RESPONSABLE DE ALMACEN

TEC. ADM. TOMÁS VÁSQUEZ OYARCE
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

TEC. ENF. RIVELINO MONTOYA CHAVEZ
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO Y SERVICIOS
AUXILIARES

I. CONDUCCION ESTRATEGICA

1. Visión y Misión DIRESA Cajamarca

Visión

“Alcanzar el bienestar biopsicosocial de las personas, familia y comunidad en un entorno saludable, con la prestación de servicios integrales de salud y el fomento del autocuidado”.

Misión

“Garantizar adecuados procesos de gestión para la atención integral de salud a favor de las comunidades de diversas culturas y creencias, proporcionándoles los medios necesarios para salvaguardar su salud, ejerciendo mayor control sobre ella y propiciando la participación activa de la sociedad civil en la región Cajamarca”

2. Visión y Misión de la Red de Salud Celendín

Misión

“La Red de Servicios de Salud Celendín es un órgano descentralizado de la DIRESA Cajamarca que tiene como finalidad proporcionar soporte técnico administrativo a las Microrredes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para brindar el cuidado integral al individuo en sus diferentes cursos de vida, familia y comunidad con un enfoque de promoción de la salud e interculturalidad de manera oportuna y adecuada”

Visión

“La Red de Servicios de Salud Celendín reconocida como una Unidad Ejecutora con un equipo multidisciplinario, técnico- administrativo comprometido en garantizar los servicios de salud con calidad, eficiencia y calidez basado en el Modelo de Cuidado Integral de Salud en atención a la persona por curso de vida, Familia y Comunidad en el marco de la implementación de la Red Integrada de Salud”

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Estructura Orgánica de la Red de Salud Cajamarca, tiene la estructura siguiente:

1. Órgano De Dirección

1.1. Dirección General

2. Órgano De Apoyo

2.1. Oficina de Recursos Humanos

2.2. Oficina de Administración

2.2.1. Oficina de Contabilidad

2.2.2. Oficina de Logística

2.2.3. Oficina de Tesorería

2.2.4. Oficina de Almacén

2.2.5. Oficina de Adquisiciones

2.2.6. Oficina de Servicios auxiliares

2.2.7. Oficina de Patrimonio

2.3. Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística

2.4. Oficina de Unidad de Seguros

2.5. Oficina de Salud Ambiental

2.6. Oficina de Emergencias y Desastres

3. Órganos de asesoramiento

3.1. Oficina de Planeamiento

3.2. Oficina de Epidemiología

4. Órganos de Línea

4.1. Oficina de Promoción de la Salud

4.2. Oficina de Atención Integral en Salud

4.3. Oficina de Servicios de Salud

4.4. Oficina de Medicamentos Insumos y Drogas

5. Órganos Desconcentrados

5.1. Microred Sucre

5.2. Microred Cortegana

5.3. Microred Miguel Iglesias

5.4. Microred Celendín

5.5. Microred Sorochuco

5.6. Microred Huasmin

5.7. Microred Pallan

5.8. Hospital de Apoyo Celendín

La presente estructura orgánica se detalla a continuación:

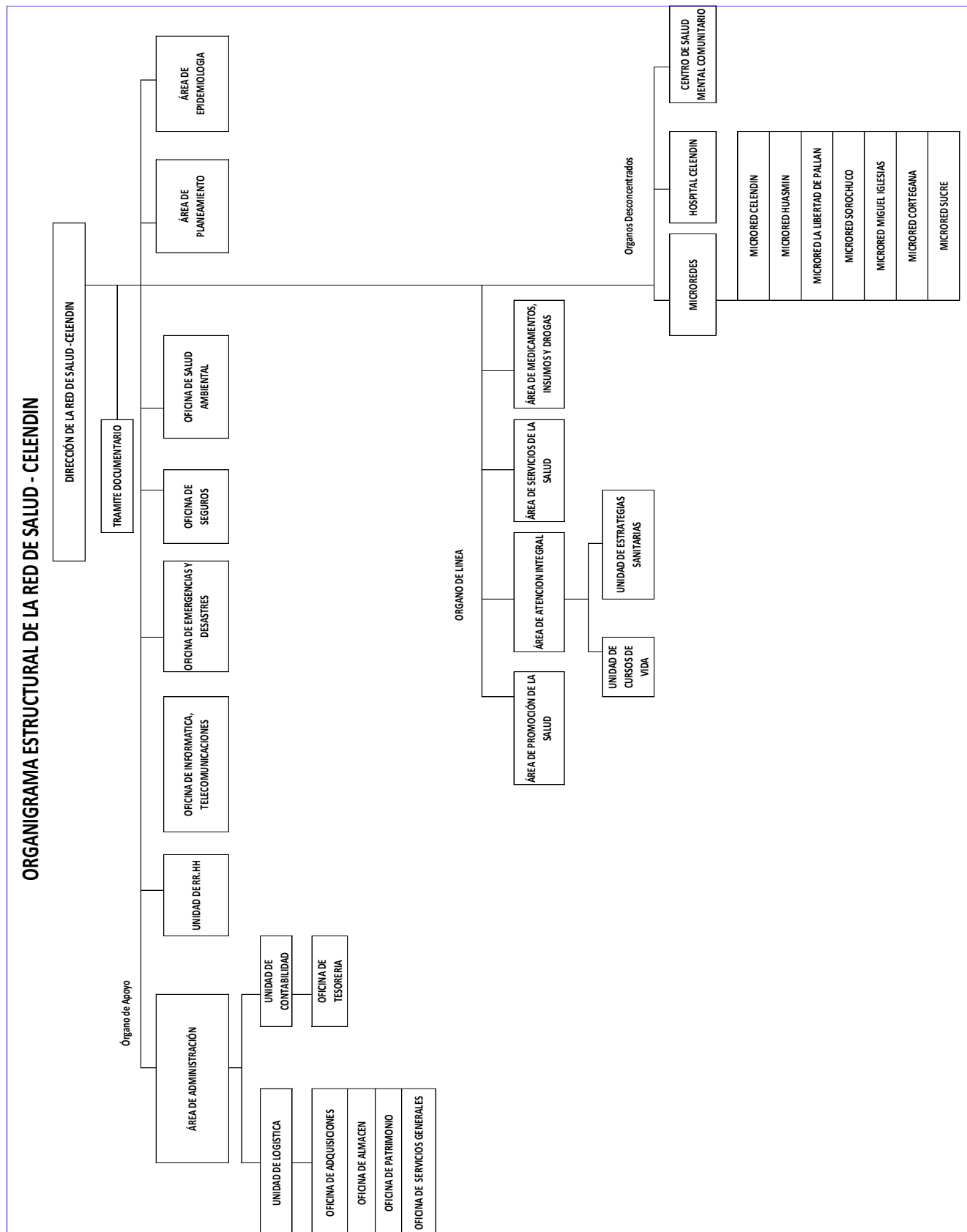


Imagen: Organigrama de la Red de Salud Cajamarca

FUNCIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

- Coordinar las acciones de Salud Integral en el ámbito de la región Celendín.
- Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de salud.
- Organizar los niveles de atención en los establecimientos de salud en la región Celendín, en coordinación con los Gobiernos Locales.
- Supervisar y controlar la comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
- Promover y preservar la Salud Ambiental de la Región.
- Ejecutar en coordinación con los Gobiernos Locales de la región acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población.

III. ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD

1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

1.1. Ubicación y límites

La provincia de Celendín se encuentra ubicada en la parte nororiental del departamento de Cajamarca, en la región sierra del Perú. Presenta una geografía variada, conformada por valles interandinos, quebradas, montañas y zonas altoandinas, características que influyen directamente en las actividades económicas, condiciones climáticas, accesibilidad y situación de salud de la población.

La provincia posee una importante diversidad ecológica y climática debido a la presencia de diferentes pisos altitudinales, permitiendo el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Asimismo, la dispersión geográfica de sus comunidades representa un reto para la provisión de servicios básicos y acceso oportuno a los establecimientos de salud, principalmente en zonas rurales alejadas.

La provincia de Celendín pertenece políticamente al departamento de Cajamarca y limita:

Por el Norte: con la provincia de Chota y la región Amazonas.

Por el Sur: con la provincia de Cajamarca.

Por el Este: con la región Amazonas.

Por el Oeste: con las provincias de Hualgayoc y Cajamarca.

El clima es variado, predominando condiciones templadas y frías según la altitud de cada distrito. Durante los meses de noviembre a abril se presenta la temporada de lluvias,

incrementándose el riesgo de deslizamientos, huaycos e interrupción de vías de comunicación.

1.2. Superficie y división política

La provincia de Celendín está ubicada aproximadamente a 2,620 m.s.n.m., cuenta con una superficie territorial aproximada de 2,658 km² y presenta una topografía accidentada característica de la sierra norte del país.

La provincia está conformada políticamente por doce distritos, siendo la capital provincial la ciudad de Celendín



Imagen: División Política, provincia de Celendín, 2026

Cada distrito presenta características geográficas, poblacionales y socioeconómicas particulares. La mayor parte de la población se encuentra distribuida en zonas rurales y centros poblados alejados, situación que condiciona el acceso a servicios de salud, educación y saneamiento básico.

Asimismo, la provincia cuenta con numerosos caseríos y centros poblados dispersos, muchos de ellos ubicados en áreas de difícil acceso geográfico, especialmente durante la época de lluvias.

1.3. Accesibilidad

La accesibilidad en la provincia de Celendín está determinada principalmente por la condición de las vías de comunicación y la geografía accidentada del territorio. La principal vía de acceso terrestre es la carretera Cajamarca – Celendín, la cual se encuentra asfaltada y permite la conexión con la capital regional.

Existen además vías de comunicación que conectan la provincia con otras regiones, como la carretera Celendín – Balsas, que facilita la comunicación con la región Amazonas. Sin embargo, gran parte de las vías interdistritales y rurales son trochas carrozables, las cuales presentan dificultades de transitabilidad durante la temporada de lluvias. En muchos distritos y centros poblados rurales, el acceso a los servicios de salud puede verse limitado debido a:

- Grandes distancias geográficas.
- Mal estado de las carreteras, deslizamientos y derrumbes.
- Limitado transporte público.
- Incremento de caudal de ríos y quebradas en épocas de lluvia.

El transporte terrestre constituye el principal medio de movilización de la población, utilizándose buses, combis, camionetas rurales y motocicletas. En las zonas más alejadas, parte de la población aún se moviliza a pie o mediante animales de carga.

Las dificultades de accesibilidad representan un importante determinante social de la salud, debido a que limitan el acceso oportuno a los establecimientos de salud, especialmente en casos de emergencias, referencias obstétricas y atención de enfermedades prioritarias.

Asimismo, las condiciones geográficas de la provincia incrementan la vulnerabilidad frente a eventos naturales como deslizamientos, inundaciones y movimientos en masa, los cuales pueden afectar temporalmente las vías de comunicación y el acceso de la población a los servicios básicos.

2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

2.1. Indicadores de Dinámica Poblacional a nivel regional

Cuadro Dinámica poblacional Celendín, 2023-2025

INDICADOR	2023	2024	2025
N° DE NACIMIENTOS	956	974	894
TASA DE NATALIDAD X 1 000	12	12	11
N° DE DEFUNCIONES	388	240	380
TASA DE MORTALIDAD X 1 000	5	3	5

Fuente: ORE Cajamarca, 2025.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2026

El escenario demográfico de la provincia de Celendín muestra variaciones importantes durante el periodo 2023–2025, principalmente en los indicadores relacionados con la natalidad y mortalidad. Durante los años 2023 y 2024 la dinámica poblacional mantiene un comportamiento relativamente estable; sin embargo, para el año 2025 se observa una reducción en los nacimientos y un incremento de las defunciones, situación que puede influir en el crecimiento poblacional y en la estructura demográfica de la provincia.

Asimismo, la natalidad presenta una tendencia descendente, pasando de 956 nacimientos en el año 2023 a 894 nacimientos en el año 2025, representando una disminución aproximada de 6,5 % en el periodo evaluado. Del mismo modo, la tasa de natalidad se mantiene en 12 nacimientos por cada 1 000 habitantes durante los años 2023 y 2024, disminuyendo a 11 por cada 1 000 habitantes en el año 2025. Este comportamiento podría estar asociado a diversos factores demográficos y socioculturales como el mayor acceso a educación, incorporación de la mujer al ámbito laboral, cambios en las decisiones reproductivas, retraso de la maternidad y un mayor acceso a métodos de planificación familiar.

Por otro lado, las defunciones presentan un comportamiento fluctuante. Entre los años 2023 y 2024 disminuyen de 388 a 240 defunciones; sin embargo, en el año 2025 se incrementan nuevamente hasta alcanzar 380 defunciones. Del mismo modo, la tasa de mortalidad disminuye de 5 a 3 defunciones por cada 1 000 habitantes entre los años 2023 y 2024, incrementándose nuevamente a 5 por cada 1 000 habitantes en el año 2025. Este comportamiento puede estar asociado a factores como el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, envejecimiento poblacional, condiciones de acceso a servicios de

salud, estilos de vida y otros determinantes sociales que influyen directamente sobre la salud de la población.

En términos generales, los indicadores demográficos evidencian una reducción progresiva de los nacimientos y fluctuaciones en la mortalidad, situación que puede afectar el crecimiento poblacional y modificar la estructura etaria de la provincia. Estos cambios requieren un seguimiento continuo para fortalecer la planificación sanitaria y orientar intervenciones que respondan a las necesidades de salud de la población.

2.2. Composición y estructura de la población

2.2.1. Población provincial por curso de vida y sexo

Cuadro Población de la provincia de Celendín por curso de vida y sexo, 2025

CURSO DE VIDA	2023		2024		2025	
	M	F	M	F	M	F
NIÑOS (0 -11 años)	9118	8856	9079	8694	8809	8401
ADOLESCENTES (12 -17 años)	4837	4787	4885	4652	4978	4768
JOVEN (18 - 29 años)	8463	8479	8379	8238	8249	8046
ADULTO (30 -59 años)	13628	14201	13505	13787	14112	13923
ADULTO MAYOR (60 a más años)	4872	5468	4828	5303	3869	4820
TOTAL	40,918	41,801	40,676	40,674	40,017	39,958

Fuente: ORE Cajamarca, 2025.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025

La estructura poblacional de la provincia de Celendín durante el periodo 2023–2025 presenta variaciones en los diferentes grupos de curso de vida, observándose una reducción progresiva de la población total. La población masculina disminuye de **40 918** habitantes en el año 2023 a **40 017** habitantes en el año 2025, mientras que la población femenina disminuye de **41 801** a **39 958** habitantes en el mismo periodo. Este comportamiento podría estar asociado a factores demográficos como la migración, disminución de la natalidad y cambios en la estructura poblacional.

En el grupo de niños (0–11 años) se evidencia una disminución sostenida tanto en hombres como en mujeres durante el periodo evaluado. La población masculina pasa de 9 118 habitantes en 2023 a 8 809 en 2025, mientras que la población femenina disminuye de 8 856 a 8 401 habitantes. Esta tendencia puede estar relacionada con la disminución progresiva de la natalidad observada en los últimos años, lo cual repercute directamente en la población infantil.

Respecto al grupo de adolescentes (12–17 años), la población presenta ligeras variaciones. En la población masculina se observa un incremento de 4 837 habitantes en 2023 a 4 978 en 2025; mientras que en la población femenina disminuye ligeramente de 4 787 a 4 768 habitantes. Este comportamiento refleja una relativa estabilidad en este grupo etario.

En el grupo de jóvenes (18–29 años) se observa una disminución tanto en hombres como en mujeres. La población masculina pasa de 8 463 habitantes en 2023 a 8 249 en 2025, y la población femenina de 8 479 a 8 046 habitantes. Esta reducción puede estar asociada a procesos migratorios hacia otras provincias o ciudades en busca de oportunidades educativas, laborales y mejores condiciones de vida.

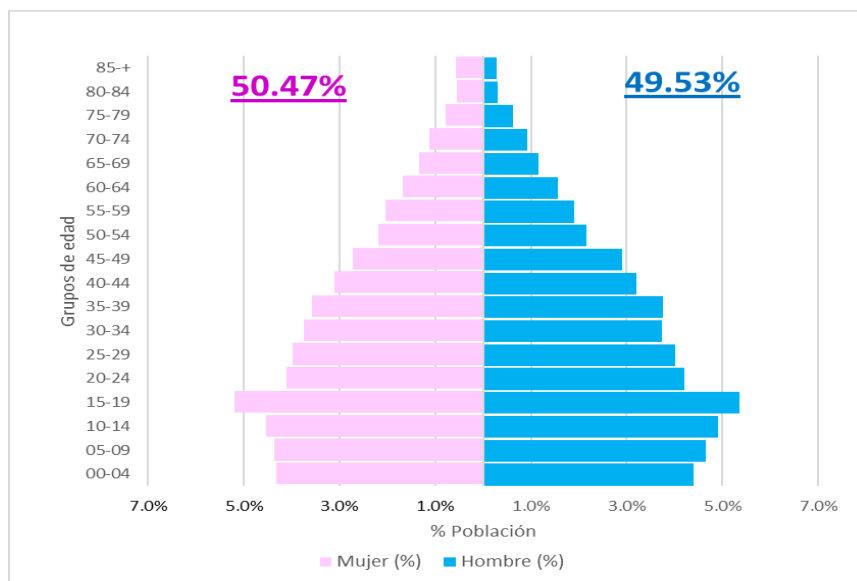
En la población adulta (30–59 años) se observa un incremento en el grupo masculino, pasando de 13 628 habitantes en 2023 a 14 112 en 2025; mientras que la población femenina disminuye ligeramente de 14 201 a 13 923 habitantes. Este grupo representa la mayor proporción poblacional y corresponde a la población económicamente activa de la provincia.

Por otro lado, en el grupo de adultos mayores (60 años a más) se evidencia una disminución tanto en hombres como en mujeres. La población masculina pasa de 4 872 habitantes en 2023 a 3 869 en 2025 y la femenina de 5 468 a 4 820 habitantes. Estas variaciones podrían estar relacionadas con factores asociados a la mortalidad y esperanza de vida.

En términos generales, la dinámica poblacional de Celendín muestra una disminución progresiva de la población total, acompañada de cambios en la distribución por grupos etarios. Estas variaciones constituyen un aspecto importante para la planificación sanitaria y social, debido a que permiten identificar necesidades específicas y orientar intervenciones dirigidas a cada etapa del curso de vida.

2.2.2. Pirámide poblacional

Gráfico Pirámide poblacional, Provincia Celendín, 2025



Fuente: ORE Cajamarca, 2025.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025

La pirámide poblacional de la provincia de Celendín para el año 2025 muestra una distribución relativamente equilibrada entre hombres y mujeres, donde la población femenina representa el 50,47 % del total y la población masculina el 49,53 %. Esta diferencia mínima evidencia una composición poblacional homogénea según sexo.

La base de la pirámide poblacional, correspondiente a los grupos de menor edad (0–14 años), presenta una amplitud moderada; sin embargo, se observa una ligera reducción en comparación con los grupos jóvenes y adultos, lo que podría indicar una disminución progresiva de la natalidad. Este comportamiento es consistente con la reducción observada en los nacimientos y podría estar relacionado con cambios demográficos y socioculturales, como la disminución de la fecundidad y cambios en las decisiones reproductivas.

Asimismo, los grupos correspondientes a la población adolescente y joven (15–29 años) presentan una mayor proporción poblacional, constituyéndose como uno de los segmentos con mayor representatividad dentro de la estructura demográfica provincial. Esto refleja la existencia de una población potencialmente activa desde el punto de vista social y económico, aunque también puede encontrarse expuesta a procesos migratorios hacia otras ciudades o regiones en búsqueda de oportunidades educativas y laborales.

En los grupos de edad adulta (30–59 años) se observa una importante concentración poblacional, lo que representa la mayor fuerza laboral y económicamente activa de la provincia. La permanencia de una proporción considerable en este grupo genera demanda de servicios relacionados con empleo, salud y protección social.

Por otro lado, la cúspide de la pirámide, correspondiente a los adultos mayores (60 años a más), presenta una reducción progresiva en el tamaño poblacional; sin embargo, mantiene una mayor proporción femenina respecto a la masculina, comportamiento que suele asociarse a una mayor esperanza de vida en mujeres.

En términos generales, la pirámide poblacional de Celendín presenta características de una población en proceso de transición demográfica, con disminución progresiva de la población infantil y una mayor concentración en grupos de edad joven y adulta. Esta estructura poblacional requiere una adecuada planificación de los servicios de salud, educación y protección social, orientada a responder a las necesidades específicas de cada grupo etario.

2.2.3. Población por provincia y distritos de Celendín, por curso de vida

Cuadro Población por provincia y distritos de Celendín, por curso de vida, 2023-2025

DISTRITO	NIÑOS (0 -11 años)	ADOLESCENTES (12 -17 años)	JOVEN (18 - 29 años)	ADULTO (30 -59 años)	TOTAL
CELENDÍN	19470	10475	16984	28620	50768
HUASMÍN	6402	3769	6481	10799	17915
CORTEGANA	4884	2767	4622	6356	12995
MIGUEL IGLESIAS	2553	1470	2530	3829	6951
CHUMUCH	1615	1044	1676	2451	4640
LA LIBERTAD DE PALLAN	3795	2297	4253	6727	11139
SOROCHUCO	4191	2179	4376	8308	11739
SUCRE	3308	1662	3040	5273	8755
OXAMARCA	4429	2155	3607	6035	10794
JOSÉ GALVEZ	1604	756	3607	2888	4114
JORGE CHAVEZ	200	72	234	564	608
UTCO	506	271	724	459	1650
Total	52957	28917	49854	83156	142068

Fuente: OITE– Red Celendín, 2025

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025.

La distribución poblacional de la provincia de Celendín muestra una mayor concentración en la etapa adulta (30–59 años) con 83 156 habitantes, representando el grupo de mayor predominio poblacional, seguido por los niños (0–11 años) con 52 957 habitantes y los jóvenes (18–29 años) con 49 854 habitantes. Los adolescentes (12–17 años) constituyen el grupo con menor proporción poblacional, con 28 917 habitantes.

Respecto a los distritos, Celendín concentra la mayor cantidad de población con 50 768 habitantes, representando aproximadamente el 35,7 % del total provincial, predominando el grupo adulto con 28 620 habitantes. Asimismo, los distritos de Huasmín (17 915 habitantes) y Cortegana (12 995 habitantes) presentan también una importante concentración poblacional. Por otro lado, los distritos con menor población corresponden a Jorge Chávez, con 608 habitantes, y Utco, con 1 650 habitantes, evidenciando una baja concentración poblacional en comparación con el resto de distritos.

En términos generales, se observa un predominio de la población en edad económicamente activa, situación que constituye un aspecto importante para la planificación de servicios de salud, educación y programas sociales dirigidos según las necesidades de cada grupo poblacional.

2.2.4. Población afiliada al SIS Provincia de Celendín

Tabla. Población afiliada al SIS Provincia de Celendín del 2023 al 2025.

PROVINCIA	2023	2024	2025
CELENDÍN	89 566	89 910	88 629

Fuente: Unidad de Seguros – DIRESA Cajamarca, 2025

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025

La población afiliada al SIS en la provincia de Celendín se mantuvo estable durante el período 2023–2025. Se registró un ligero incremento de afiliados entre 2023 y 2024, pasando de 89 566 a 89 910 asegurados; sin embargo, en 2025 se observó una disminución a 88 629 afiliados. A pesar de esta reducción, la provincia mantiene una alta cobertura de aseguramiento en salud, lo que favorece el acceso de la población a los servicios de salud y contribuye a la protección sanitaria de los grupos más vulnerables.

2.2.5. Población afiliada al SIS por distrito 2023 al 2025

Tabla. Afiliados al SIS por distritos, provincia Celendín, 2023 – 2025

DISTRITO	2023	2024	2025
CELENDÍN	25847	25354	27063
HUASMÍN	13261	13902	12921
CORTEGANA	8126	8530	7945
MIGUEL IGLESIAS	4688	4911	4452
CHUMUCH	3058	3235	2935
LA LIBERTAD DE PALLAN	7500	7776	7277
SOROCHUCO	9309	9799	9089
SUCRE	5655	5685	5645
OXAMARCA	6942	7196	6797
JOSÉ GALVEZ	2866	2944	2839
JORGE CHAVEZ	492	546	499
UTCO	1186	1264	1140
Total	88 930	91 142	88 602

Fuente: Unidad de Seguros – DIRESA Cajamarca, 2025

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025

El distrito de Celendín concentra la mayor cantidad de afiliados durante todo el período, alcanzando 27 063 afiliados en 2025, seguido por Huasmín (12 921) y Sorochuco (9 089), reflejando una mayor demanda potencial de servicios de salud en estos distritos. Por el contrario, Jorge Chávez y Utco registran el menor número de afiliados, debido principalmente a su menor tamaño poblacional.

En general, la mayoría de distritos presentan una reducción de afiliados en 2025 respecto al año anterior; sin embargo, Celendín fue el único distrito que mostró un incremento importante, pasando de 25 354 afiliados en 2024 a 27 063 en 2025. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer los procesos de afiliación y actualización del padrón de asegurados, garantizando el acceso de la población a los servicios de salud y la continuidad de la cobertura sanitaria en toda la provincia.

3. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES

3.1. Determinantes socioeconómicos

3.1.1. Pobreza

Tabla. Pobreza monetaria por distritos, provincia Celendín, 2025

DISTRITO	%
CELENDIN	35.1
CHUMUCH	65.1
CORTEGANA	72.3
HUASMIN	76.1
JORGE CHAVEZ	48.9
JOSE GALVEZ	47.8
LA LIBERTAD DE PALLAN	68.7
MIGUEL IGLESIAS	75.8
OXAMARCA	81
SOROCHUCO	66.2
SUCRE	53.9
UTCO	66.8
PROVINCIAL	59.6

Fuente: ORE Cajamarca, 2025.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red Celendín, 2025

La provincia de Celendín presenta un nivel de pobreza económica de 59.6%, lo que indica que más de la mitad de su población enfrenta condiciones económicas limitadas, constituyéndose en un factor que puede influir en el acceso a servicios básicos, salud, educación y calidad de vida.

A nivel distrital, se observa una marcada variabilidad. Los distritos con mayores porcentajes de pobreza son Oxamarca (81%), Huasmin (76.1%), Miguel Iglesias (75.8%) y Cortegana (72.3%), evidenciando una alta vulnerabilidad socioeconómica y una mayor necesidad de intervenciones y programas sociales priorizados.

Por otro lado, los distritos con menores porcentajes de pobreza corresponden a Celendín (35.1%), José Gálvez (47.8%) y Jorge Chávez (48.9%), los cuales muestran mejores condiciones económicas en comparación con el promedio provincial. En términos generales, los datos reflejan desigualdades importantes entre los distritos de la provincia, siendo necesario fortalecer estrategias orientadas a reducir las brechas económicas y mejorar las condiciones de desarrollo de los distritos con mayor afectación.

3.1.2. Educación

Tabla. Número de personas con analfabetismo por distritos, provincia
Celendín, 2025

DISTRITO	%
CELENDIN	11.2
CHUMUCH	16.1
CORTEGANA	21.8
HUASMIN	22.9
JORGE CHAVEZ	6.0
JOSE GALVEZ	14.5
LA LIBERTAD DE PALLAN	15.6
MIGUEL IGLESIAS	14.2
OXAMARCA	14.1
SOROCHUCO	22.7
SUCRE	10.8
UTCO	16.2
PROVINCIAL	15.9

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

La provincia de Celendín registra un indicador educativo de 15.9 %, evidenciando que una parte importante de la población presenta limitaciones educativas, lo cual puede influir en el acceso a mejores oportunidades de desarrollo social y económico. A nivel distrital, Huasmin (22.9 %), Sorochocho (22.7 %) y Cortegana (21.8 %) presentan los porcentajes más elevados, situación que podría estar asociada a factores como la ruralidad, dispersión geográfica de las comunidades y limitaciones en el acceso a servicios educativos. En comparación, los distritos de Jorge Chávez (6.0 %), Sucre (10.8 %) y Celendín (11.2 %) muestran menores porcentajes, lo que podría relacionarse con una mayor disponibilidad y accesibilidad a servicios educativos. Estos resultados evidencian desigualdades entre distritos y resaltan la necesidad de fortalecer estrategias para reducir las brechas educativas existentes.

3.1.3. Desempleo

Tabla. Porcentaje de desempleo por distritos, provincia Celendín, 2025

Distrito	%
CELENDIN	4.2
CHUMUCH	4.8
CORTEGANA	2.7
HUASMIN	2.8
JORGE CHAVEZ	12.5
JOSE GALVEZ	2.5
LA LIBERTAD DE PALLAN	2.9
MIGUEL IGLESIAS	0.7
OXAMARCA	5.6
SOROCHUCO	2.4
SUCRE	1.4
UTCO	1.4
PROVINCIAL	3.7

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Celendín

La provincia de Celendín registra una tasa de desempleo de 3.7 %, indicando que una proporción de la población económicamente activa se encuentra sin acceso a oportunidades laborales. A nivel distrital, Jorge Chávez (12.5 %) y Oxamarca (5.6 %) presentan los porcentajes más altos de desempleo, lo que podría estar asociado a limitadas oportunidades de empleo formal, dependencia de actividades económicas estacionales y menor dinamismo económico local. En comparación, los distritos de Miguel Iglesias (0.7 %), Sucre (1.4 %) y Utco (1.4 %) presentan menores porcentajes de desempleo, posiblemente relacionados con una mayor participación de la población en actividades productivas locales, principalmente agrícolas o de autoempleo. En general, los resultados muestran diferencias entre distritos, evidenciando la necesidad de fortalecer estrategias orientadas a generar mayores oportunidades laborales y mejorar las condiciones económicas de la población.

3.1.4. Dependencia económica

Tabla. Porcentaje de hogares con dependencia económica por distritos, provincia Celendín 2025

Distrito	%
CELENDIN	63.9
CHUMUCH	85.2
CORTEGANA	83.5
HUASMIN	67.5
JORGE CHAVEZ	75
JOSE GALVEZ	77.6
LA LIBERTAD DE PALLAN	68.3
MIGUEL IGLESIAS	69.4
OXAMARCA	72.5
SOROCHUCO	66
SUCRE	70.1
UTCO	72.2
PROVINCIAL	72.6

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

La provincia de Celendín registra una dependencia económica de 72.6 %, lo que indica que existe una elevada proporción de población dependiente respecto a la población en edad económicamente activa, generando una mayor carga económica sobre quienes participan directamente en actividades productivas. A nivel distrital, Chumuch (85.2 %) y Cortegana (83.5 %) presentan los porcentajes más altos de dependencia económica, situación que podría estar asociada a una mayor presencia de población infantil y adulta mayor, así como a menores oportunidades de inserción laboral. En comparación, los distritos de Celendín (63.9 %), Sorochuco (66 %) y Huasmin (67.5 %) muestran menores niveles de dependencia económica, reflejando una relación más favorable entre la población dependiente y la población económicamente activa. En términos generales, los resultados evidencian diferencias entre los distritos de la provincia y resaltan la necesidad de fortalecer estrategias orientadas al desarrollo económico y generación de oportunidades productivas.

3.1.5. Densidad del estado

Tabla. Porcentaje de densidad del estado por distritos, provincia Celendín, 2025

Distrito	%
CELENDIN	0.73
CHUMUCH	0.47
CORTEGANA	0.46
HUASMIN	0.50
JORGE CHAVEZ	0.60
JOSE GALVEZ	0.58
LA LIBERTAD DE PALLAN	0.49
MIGUEL IGLESIAS	0.53
OXAMARCA	0.46
SOROCHUCO	0.50
SUCRE	0.57
UTCO	0.46
PROVINCIAL	0.58

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

La provincia de Celendín presenta una densidad del Estado de 0.58, lo que evidencia una disponibilidad limitada de presencia estatal y acceso a servicios públicos en relación con la población. Este indicador refleja el nivel de acceso de la población a servicios e instituciones del Estado que contribuyen al bienestar y desarrollo social.

A nivel distrital, Celendín (0.73) y Jorge Chávez (0.60) presentan los valores más altos, lo que podría estar relacionado con una mayor concentración de servicios públicos, infraestructura y presencia institucional. En comparación, los distritos de Cortegana (0.46), Oxamarca (0.46) y Utco (0.46) presentan los menores valores, situación que podría asociarse a factores como la dispersión geográfica, ruralidad y dificultades en el acceso a servicios básicos y entidades estatales.

En general, los resultados muestran diferencias entre distritos, evidenciando brechas en la presencia y cobertura de servicios estatales dentro de la provincia, por lo que resulta importante fortalecer estrategias que permitan mejorar el acceso equitativo a servicios públicos y reducir las desigualdades territoriales.

3.2. Circunstancias materiales

3.2.1. Viviendas con acceso a agua potable

Tabla. Porcentaje de Viviendas con acceso a agua potable, provincia de Celendín, 2025.

Distrito	%
CELENDIN	59.3 %
CHUMUCH	33.8 %
CORTEGANA	33.1 %
HUASMIN	42.7 %
JORGE CHAVEZ	37.1 %
JOSE GALVEZ	35.4 %
LA LIBERTAD DE PALLAN	40.8 %
MIGUEL IGLESIAS	51.8 %
OXAMARCA	29.1 %
SOROCHUCO	39.1 %
SUCRE	51.4 %
UTCO	37.3 %
PROVINCIAL	45.6 %

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

En el año 2025, la provincia de Celendín registró una cobertura provincial de 45,6% de viviendas con acceso a agua potable, evidenciando que menos de la mitad de los hogares cuentan con este servicio básico, lo que representa una importante brecha en el acceso al saneamiento y constituye un determinante social que puede afectar la salud de la población.

A nivel distrital, Celendín presentó la mayor cobertura con 59,3%, seguido de Miguel Iglesias (51,8%) y Sucre (51,4%), siendo los únicos distritos que superan el 50% de acceso. Por el contrario, Oxamarca (29,1%), Cortegana (33,1%) y Chumuch (33,8%) registraron las coberturas más bajas, reflejando mayores limitaciones en el acceso a este servicio esencial.

Las diferencias observadas entre distritos evidencian desigualdades en las condiciones de saneamiento básico dentro de la provincia. La limitada cobertura de agua potable incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el consumo

de agua insegura, especialmente enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, afectando principalmente a la población infantil y grupos vulnerables

3.2.2. Viviendas con acceso a desagüe

Tabla. Porcentaje de Viviendas con acceso a desagüe, provincia de Celendín, 2025.

Distrito	%
CELENDIN	68.3 %
CHUMUCH	66.0 %
CORTEGANA	64.7 %
HUASMIN	64.6 %
JORGE CHAVEZ	38.7 %
JOSE GALVEZ	51.9 %
LA LIBERTAD DE PALLAN	74.4 %
MIGUEL IGLESIAS	73.8 %
OXAMARCA	58.2 %
SOROCHUCO	55.6 %
SUCRE	63.6 %
UTCO	47.4 %
PROVINCIAL	64.2 %

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

En el año 2025, la provincia de Celendín registró una cobertura provincial de 64,2% de viviendas con acceso a servicio de desagüe, lo que indica que aproximadamente dos de cada tres viviendas cuentan con este servicio básico de saneamiento. Sin embargo, aún persisten brechas importantes en algunos distritos de la provincia.

A nivel distrital, los mayores porcentajes de acceso se registraron en La Libertad de Pallán (74,4%), Miguel Iglesias (73,8%) y Celendín (68,3%), evidenciando mejores condiciones de saneamiento en comparación con el resto de distritos. Por otro lado, Jorge Chávez (38,7%), Utco (47,4%) y José Gálvez (51,9%) presentaron las coberturas más bajas, reflejando limitaciones en el acceso a este servicio esencial.

Las diferencias observadas entre distritos ponen en evidencia desigualdades en las condiciones de saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales. La falta de

acceso a sistemas adecuados de eliminación de excretas puede incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales, afectando principalmente a la población infantil y a los grupos más vulnerables.

3.2.3. Hacinamiento

Tabla. Porcentaje de Hacinamiento en la Provincia de Celendín, 2025.

Distrito	%
CELENDIN	14.8 %
CHUMUCH	33.6 %
CORTEGANA	47.2 %
HUASMIN	25.5 %
JORGE CHAVEZ	13.2 %
JOSE GALVEZ	10.8 %
LA LIBERTAD DE PALLAN	29.4 %
MIGUEL IGLESIAS	26.7 %
OXAMARCA	26.7 %
SOROCHUCO	12.4 %
SUCRE	13.6 %
UTCO	18.5 %
PROVINCIAL	22.7 %

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

En el año 2025, la provincia de Celendín registró un 22,7% de hacinamiento, lo que indica que aproximadamente una de cada cinco viviendas presenta una ocupación superior a la capacidad adecuada de alojamiento. Esta situación constituye un importante determinante social de la salud, debido a que favorece la transmisión de enfermedades respiratorias, infecciosas y otros problemas relacionados con las condiciones inadecuadas de vivienda.

A nivel distrital, Cortegana (47,2%) presentó el mayor porcentaje de hacinamiento, seguido de Chumuch (33,6%) y La Libertad de Pallán (29,4%), evidenciando condiciones de vivienda más desfavorables. Por el contrario, los menores porcentajes se registraron en José Gálvez (10,8%), Sorochuco (12,4%) y Jorge Chávez (13,2%), mostrando mejores condiciones habitacionales en comparación con el resto de distritos.

Asimismo, los distritos de Huasmin (25,5%), Miguel Iglesias (26,7%) y Oxamarca (26,7%) presentan porcentajes superiores al promedio provincial, lo que refleja la necesidad de fortalecer las intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de vivienda y reducir los factores de riesgo asociados al hacinamiento.

3.2.4. Hogares que cocinan con leña y/o estiércol

Tabla. Porcentaje de Hogares que cocinan con leña y/o estiércol en la Provincia de Celendín, 2025.

Distrito	%
CELENDIN	46.7 %
CHUMUCH	64.3 %
CORTEGANA	63.9 %
HUASMIN	65.1 %
JORGE CHAVEZ	39.7 %
JOSE GALVEZ	48.8 %
LA LIBERTAD DE PALLAN	70.9 %
MIGUEL IGLESIAS	69.7 %
OXAMARCA	63.2 %
SOROCHUCO	57.5 %
SUCRE	57.1 %
UTCO	50.4 %
PROVINCIAL	58.1 %

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

En el año 2025, la provincia de Celendín registró un 58,1% de hogares que cocinan con leña y/o estiércol, lo que indica que más de la mitad de las viviendas de la provincia depende del uso de biomasa para la preparación de sus alimentos. Esta situación constituye un crítico determinante ambiental de la salud, debido a que la combustión interna genera una alta exposición a contaminantes intramurales que afectan directamente la mucosa respiratoria, favoreciendo el desarrollo de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), neumonías y otras patologías broncopulmonares crónicas, especialmente en la población infantil menor de 5 años.

A nivel distrital, La Libertad de Pallán (70,9%) presentó el mayor porcentaje de uso de biomasa, seguido estrechamente por Miguel Iglesias (69,7%) y Huasmin

(65,1%), evidenciando condiciones de vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad social más desfavorables para estas comunidades. Por el contrario, los menores porcentajes de exposición a este factor de riesgo se registraron en Jorge Chávez (39,7%), Celendín (46,7%) y José Gálvez (48,8%), mostrando mejores condiciones de transición energética o acceso a combustibles limpios en comparación con el resto de la provincia.

Asimismo, los distritos de Chumuch (64,3%), Cortegana (63,9%) y Oxamarca (63,2%) presentan porcentajes considerablemente superiores al promedio provincial, lo que refleja la necesidad urgente de fortalecer las intervenciones sanitarias y multisectoriales (como la implementación de cocinas mejoradas y programas de electrificación/gasificación) orientadas a reducir la contaminación del aire de interiores y mitigar la incidencia de enfermedades respiratorias.

3.3. Factores Psicosociales

3.3.1. Migración

Tabla. Porcentaje de Migración en la Provincia de Celendín, 2025

Distrito	%
CELENDIN	28.03 %
CHUMUCH	5.37 %
CORTEGANA	3.83 %
HUASMIN	3.24 %
JORGE CHAVEZ	22.09 %
JOSE GALVEZ	42.07 %
LA LIBERTAD DE PALLAN	4.78 %
MIGUEL IGLESIAS	5.89 %
OXAMARCA	2.05 %
SOROCHUCO	2.28 %
SUCRE	9.39 %
UTCO	18.06 %
PROVINCIAL	12.50 %

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública - 2027

Elaborado: Oficina Epidemiología Red Celendín

En el año 2025, la provincia de Celendín registró un 12,50% de migración, lo que indica que aproximadamente uno de cada ocho pobladores o familias se desplaza fuera de su lugar de origen de manera temporal o permanente. Esta situación constituye un determinante demográfico y social de la salud relevante, debido a que los flujos migratorios impactan directamente en la continuidad del cuidado médico (como los esquemas de vacunación infantil y controles de gestantes), modifican la densidad poblacional y pueden alterar el perfil epidemiológico local mediante la introducción de agentes patógenos o la exposición a nuevos riesgos sanitarios en las zonas de destino.

A nivel distrital, José Gálvez (42,07%) presentó el mayor porcentaje de migración con una diferencia muy marcada respecto al resto, seguido de Celendín (28,03%) y Jorge Chávez (22,09%), evidenciando dinámicas de movilidad poblacional mucho más intensas en estas jurisdicciones. Por el contrario, los menores porcentajes se registraron en Oxamarca (2,05%), Sorochuco (2,28%) y Huasmín (3,24%), mostrando poblaciones con un arraigo geográfico mucho más estable y menor exposición a los factores de vulnerabilidad asociados al desplazamiento.

Asimismo, el distrito de Utcó (18,06%) también presenta un porcentaje significativamente superior al promedio provincial, lo que refleja la necesidad de adaptar las estrategias de vigilancia epidemiológica y los programas de atención primaria en estas zonas de alta movilidad, asegurando mecanismos que garanticen el seguimiento de pacientes y la cobertura de los servicios de salud a pesar de los flujos migratorios.

3.4. Sistemas de Salud

3.4.1. Establecimientos de la Red de Salud Celendín

DISTRITO	N° EE.SS	CATEGORIA			
		I-1	I-2	I-3	II-1
CELENDIN	7	3		1	1
CORTEGANA	7	6	0	1	0
MIGUEL IGLESIAS	5	4	0	1	0
CHUMUCH	2	2			
LA LIBERTAD DE PALLAN	3	2	1		
HUASMIN	9	8	1		
SOROCHUCO	7	6	1		

OXAMARCA	3	1	2		
SUCRE	5	4	0	1	
JOSE GALVEZ	2	1	1		
JORGE CHAVEZ	1	1			
UTCO LIMON	1	1			
PROVINCIA CELENDIN	50	39	6	4	1

Fuente. Oficina de Epidemiología Red Celendín

La Red de Salud Celendín cuenta con establecimientos de salud categorizados de acuerdo con su nivel de complejidad y capacidad resolutive, los cuales permiten organizar la oferta de servicios de salud de acuerdo con las necesidades de la población. La categorización considera aspectos relacionados con la cartera de servicios, infraestructura, equipamiento, recursos humanos y capacidad para brindar prestaciones de salud.

Los **establecimientos I-1** corresponden al primer nivel de atención con menor capacidad resolutive y están orientados principalmente a desarrollar actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención de problemas de salud de baja complejidad. Los **establecimientos I-2** presentan una mayor capacidad resolutive y brindan atención integral ambulatoria, fortaleciendo las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.

Los **establecimientos I-3** corresponden a centros de salud con mayor capacidad resolutive dentro del primer nivel de atención, que brindan atención médica ambulatoria y cuentan con una cartera de servicios más amplia, de acuerdo con su categorización y disponibilidad de recursos. Por su parte, los **establecimientos II-1** corresponden al segundo nivel de atención y tienen capacidad para brindar atención especializada, además de servicios de mayor complejidad, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada.

La provincia de Celendín cuenta con 50 establecimientos de salud distribuidos en sus 12 distritos, predominando los establecimientos del primer nivel de atención. Del total, el 78% corresponde a la categoría I-1, el 12% a I-2, el 8% a I-3 y únicamente el 2% a la categoría II-1, ubicada en la ciudad de Celendín. Esta distribución evidencia un modelo de atención enfocado principalmente en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención de problemas de baja complejidad.

La distribución de los establecimientos no es homogénea entre los distritos. Huasmín concentra el mayor número de establecimientos de salud, mientras que Jorge Chávez y Utcó cuentan con un solo establecimiento cada uno, lo que puede dificultar el acceso oportuno de la población, especialmente en las zonas rurales dispersas. Asimismo, solo los distritos de Celendín, Cortegana, Miguel Iglesias y Sucre disponen de establecimientos de categoría I-3, mientras que el único establecimiento II-1 funciona como centro de referencia para toda la provincia, generando dependencia del sistema de referencia para la atención de casos de mayor complejidad.

En conjunto, la red de servicios garantiza una adecuada cobertura del primer nivel de atención; sin embargo, persisten brechas en la capacidad resolutive, infraestructura, equipamiento y disponibilidad de servicios especializados. Por ello, es necesario fortalecer el primer nivel mediante la mejora de recursos humanos, equipamiento y abastecimiento de medicamentos, optimizar el sistema de referencia y contrarreferencia, y evaluar la recategorización de establecimientos estratégicos para mejorar el acceso y la oportunidad de atención de la población de la provincia de Celendín.

3.4.2. Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas y Esenciales (FONE)

DISTRITOS	FUNCIONES OBSTETRICAS		CAPACIDAD RESOLUTIVA AÑO 2025				
	FONP	FONE	Menor de 10%	De 10 a 39.9%	De 40 a 69.9%	De 70 a 89.9%	De 90% a más
CELENDIN	3	1			62.2%		
SOROCHUCO	7				67.1%		
HUASMIN	9				66.4%		
UTCÓ	1					73.3%	
SUCRE	4					70.7%	
JOSE GALVEZ	2					72.1%	
JORGE CHAVEZ	1				50.9%		
OXAMARCA	4				66.7%		
CORTEGANA	7				65.9%		
MIGUEL IGLESIAS	5				68.9%		
CHUMUCH	2					75.9%	
LA LIBERTAD DE PALLAN	3					73.5%	
PROVINCIA DE CELENDIN	48	1			64.0%	73.10%	

FUENTE. Oficina de Atención Integral Red Celendín

-FONP (Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas)

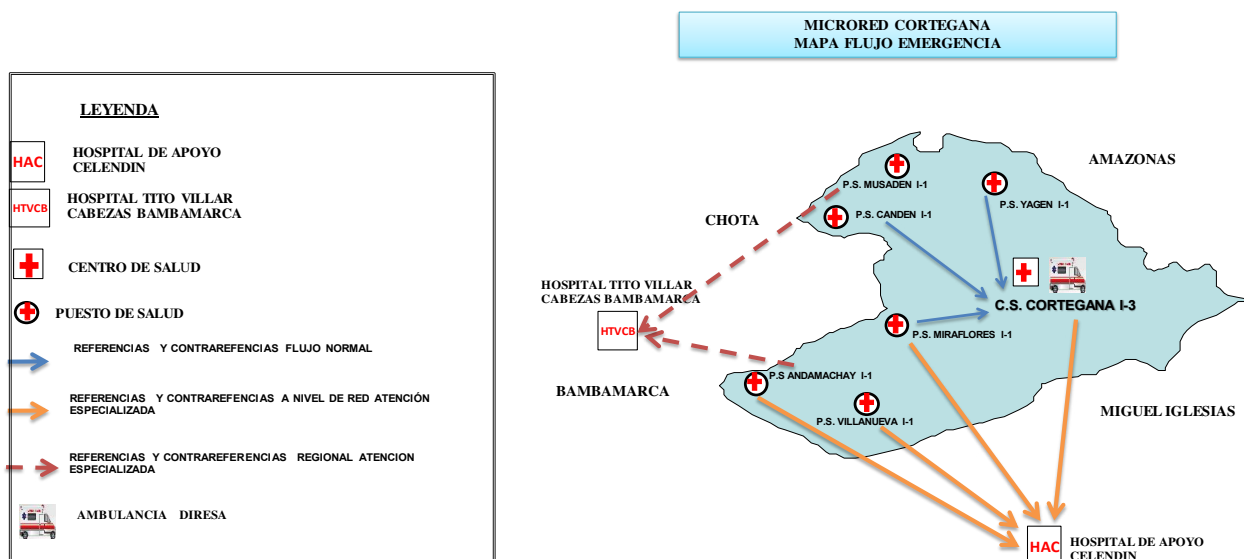
-FONE (Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales)

En la provincia de Celendín, durante el año 2025, se cuenta con **48 establecimientos de salud con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONP)** y sólo el Hospital de Apoyo Celendín es con Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales. Los distritos presentan variabilidad en su capacidad resolutive, destacando mejores resultados en **Chumuch (75,9%), Utco (73,3%), La Libertad de Pallán (73,5%), José Gálvez (72,1%) y Sucre (70,7%)**; mientras que algunos distritos requieren fortalecer sus capacidades para garantizar una atención obstétrica y neonatal oportuna.

Estos resultados evidencian la necesidad de continuar mejorando la infraestructura, equipamiento, disponibilidad de recursos humanos y fortalecimiento de competencias del personal de salud, con énfasis en la atención materna y neonatal para reducir riesgos y complicaciones en la población gestante y recién nacida.

3.4.3. Referencias y Contrarreferencias: indicadores y Mapa de Flujo de Referencias

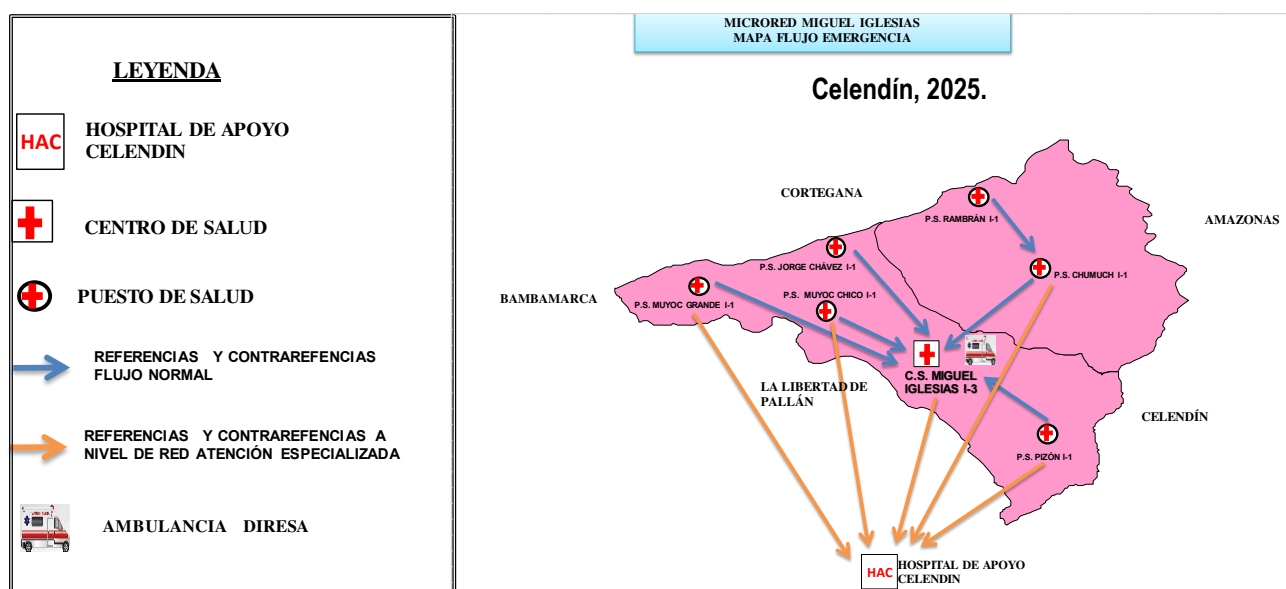
Mapa. Flujo de referencia Microred Cortegana de la Provincia de Celendín, 2025.



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

El mapa de flujo de referencias de la Microred Cortegana consolida un sistema articulado de referencias donde los puestos de salud periféricos (Yagen, Musaden, Candén y Miraflores) canalizan sus urgencias habituales hacia el Centro de Salud Cortegana (I-3) como nodo de contención primaria, mientras que las comunidades con mayor proximidad geográfica a otras provincias, como Andamachay y Villanueva, activan corredores directos de atención especializada hacia el Hospital de Apoyo Celendín y el Hospital Tito Villar Cabezas de Bambamarca; un diseño organizativo que, en coordinación con el establecimiento de referencia, resulta vital para mitigar las barreras geográficas y asegurar la evacuación oportuna de pacientes críticos en la región.

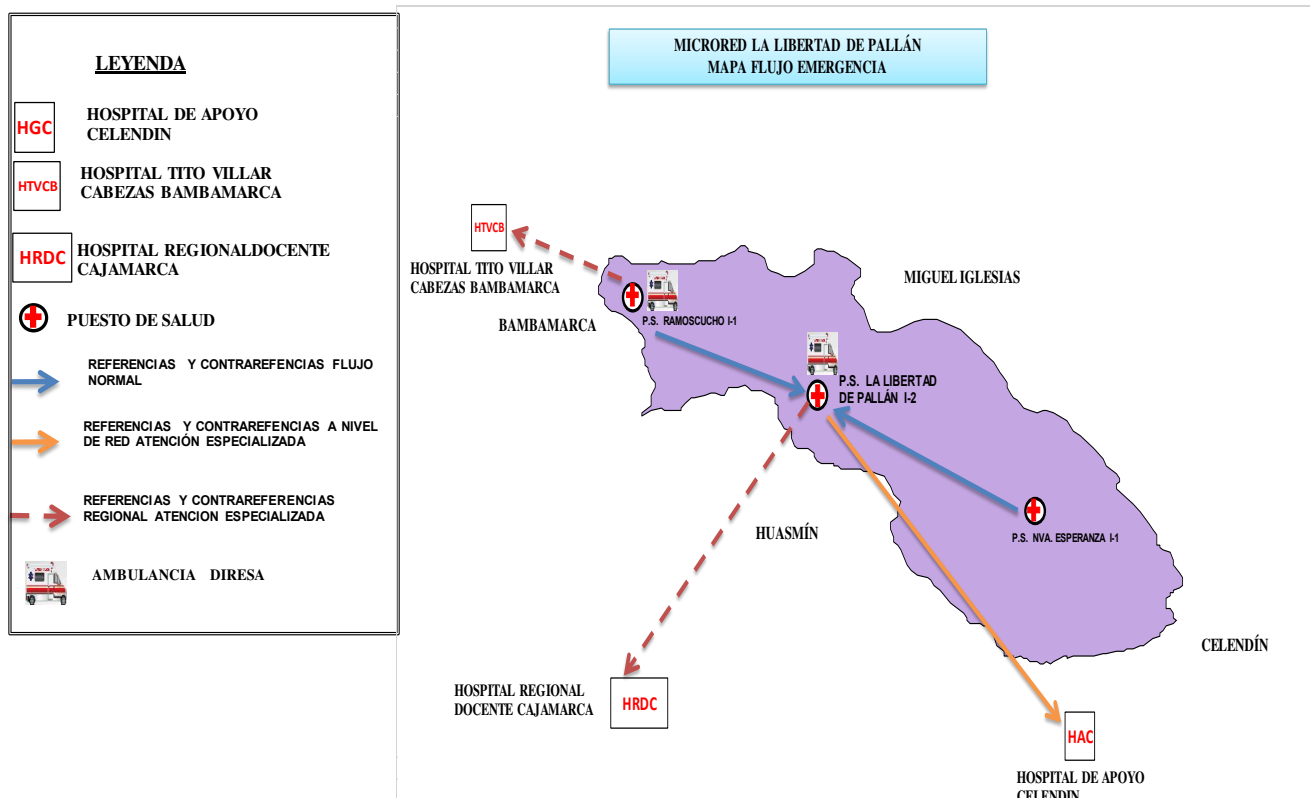
Mapa. Flujo de referencia Microred Miguel Iglesias de la Provincia de



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred Miguel Iglesias expone un sistema estructurado de evacuación sanitaria donde el Centro de Salud Miguel Iglesias (I-3) funciona como el núcleo receptor de la casuística normal proveniente de los puestos de salud de Muyoc Chico (I-1), Jorge Chávez (I-1), Rambrán (I-1), Chumuch (I-1) y Pizón (I-1); en tanto, los pacientes que presentan cuadros críticos o requieren cuidados de mayor complejidad médica son derivados mediante ambulancias hacia el Hospital de Apoyo Celendín (HAC) a través de corredores de atención especializada directa, una ruta que también activan de manera independiente los establecimientos de Muyoc Grande (I-1) y el propio centro nodal para optimizar los tiempos de respuesta y asegurar la supervivencia del paciente en la periferie de la provincia.

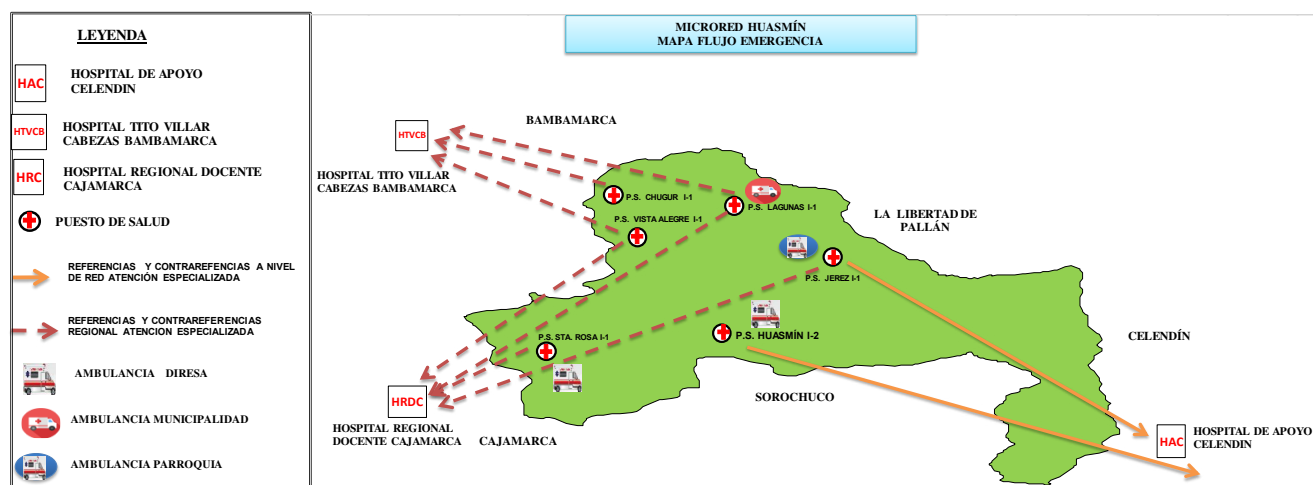
Mapa. Flujo de referencia Microred la Libertad de Pallán de la Provincia de
Celendín, 2025.



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred La Libertad de Pallán establece una red de evacuación altamente diversificada donde el Puesto de Salud La Libertad de Pallán (I-2) centraliza el flujo normal de referencias proveniente de las localidades periféricas de Ramoscucho (I-1) y Nueva Esperanza (I-1); sin embargo, debido a su ubicación geográfica estratégica, la microred activa tres rutas diferenciadas para casos de alta complejidad médica: una vía directa de atención especializada provincial hacia el Hospital de Apoyo Celendín (HAC) y dos corredores críticos de atención especializada regional operados por ambulancias que conectan a Ramoscucho con el Hospital Tito Villar Cabezas de Bambamarca (HTVCB) y al nodo principal de Pallán directamente con el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC) para garantizar una respuesta médica inmediata y de alta resolución.

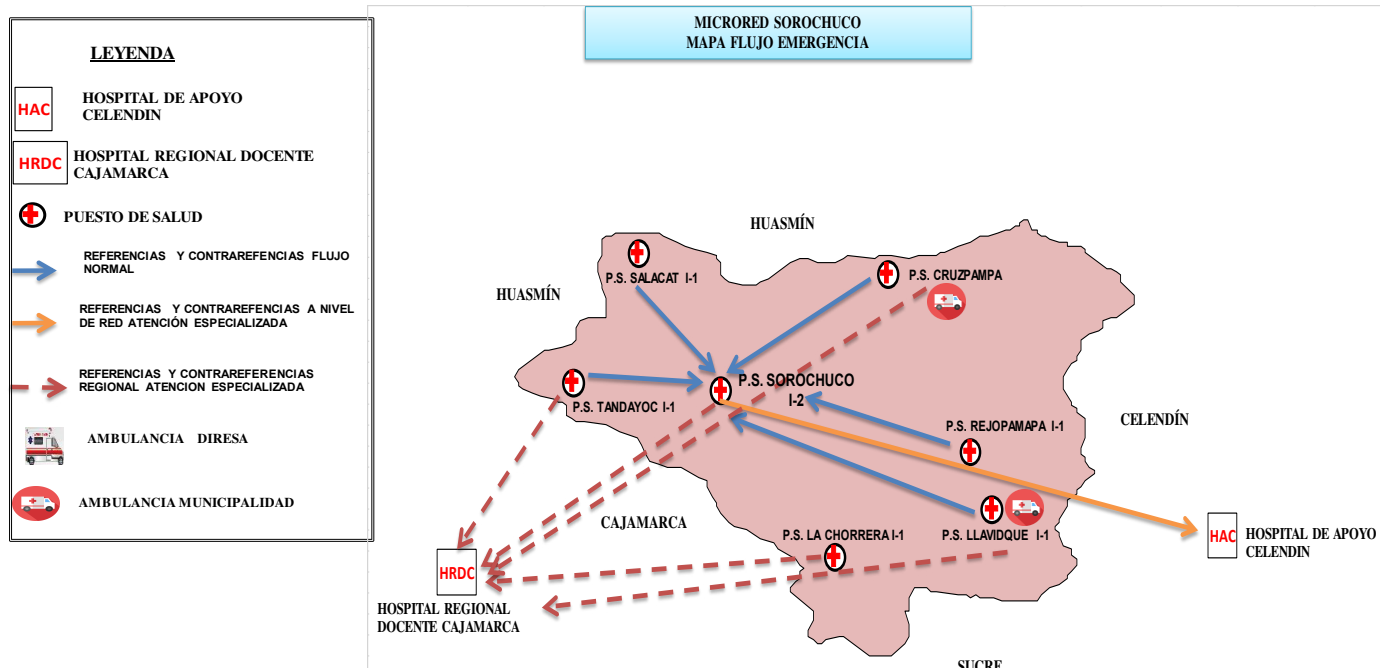
Mapa. Flujo de referencia Microred Huasmín de la Provincia de Celendín,
2025.



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred Huasmín expone un sistema descentralizado y de alta complejidad geográfica donde las referencias de nivel especializado provincial se canalizan desde el P.S. Huasmín (I-2) y el P.S. Jerez (I-1) en ruta directa hacia el Hospital de Apoyo Celendín (HAC); de manera paralela, la microred optimiza la evacuación de pacientes críticos mediante el soporte logístico de ambulancias de la Diresa y municipales, activando eficientes corredores de atención especializada regional que conectan de forma independiente a los establecimientos del sector norte, como P.S. Chugur (I-1) y P.S. Vista Alegre (I-1), con el Hospital Tito Villar Cabezas Bambamarca (HTVCB), mientras que el P.S. Santa Rosa (I-1) establece un corredor directo hacia el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC) para mitigar las barreras de distancia y asegurar la supervivencia del paciente en situaciones de urgencia médica extrema.

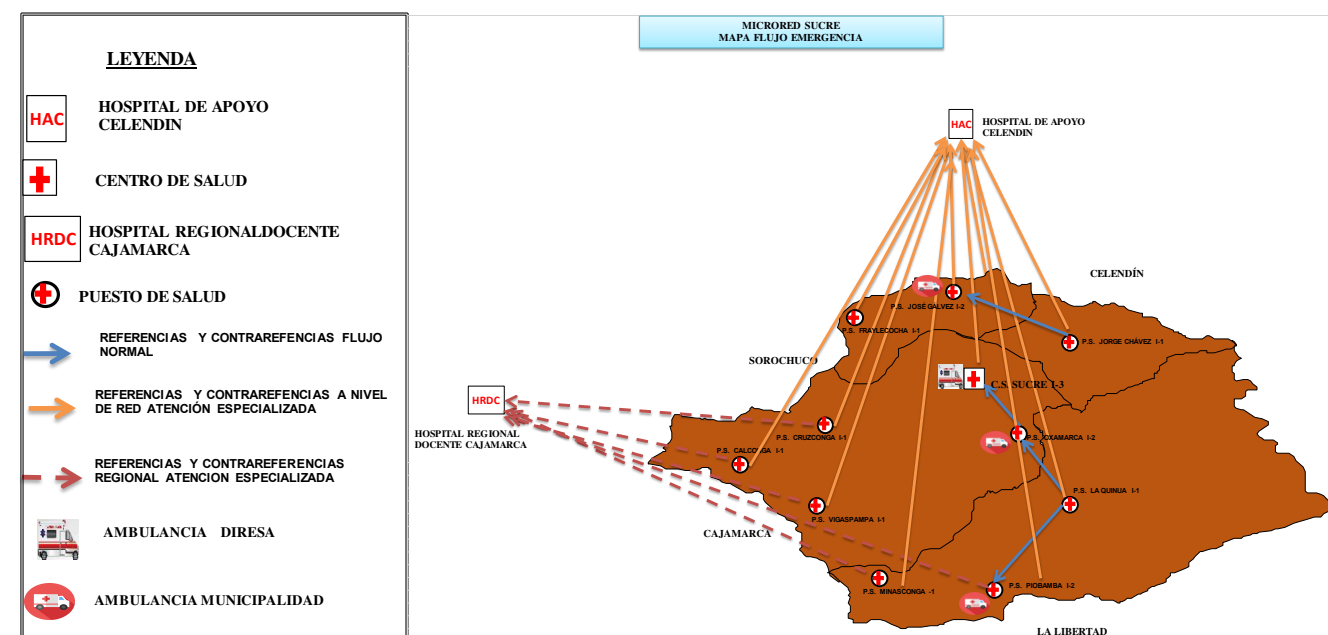
Mapa. Flujo de referencia Microred Sorochocho de la Provincia de Celendín,
2025.



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred Sorochocho detalla una red asistencial fuertemente integrada donde el Puesto de Salud Sorochocho (I-2) opera como el nodo de contención primaria, absorbiendo el flujo normal de referencias proveniente de los establecimientos periféricos de Salacat (I-1), Tandayoc (I-1), Cruzpampa, Rejopampa (I-1) y Llavidque (I-1). Para casos de mayor complejidad médica, el propio establecimiento central de Sorochocho activa una ruta de atención especializada provincial hacia el Hospital de Apoyo Celendín (HAC); de forma simultánea, y con el soporte de las ambulancias de la DIRESA distribuidas en puntos estratégicos como Cruzpampa y Llavidque, la microred dispone de un corredor crítico de atención especializada que conecta de manera directa y preferencial a los puestos de Tandayoc, Sorochocho, La Chorrera (I-1) y Llavidque con el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC), garantizando una evacuación oportuna ante urgencias de alta resolución

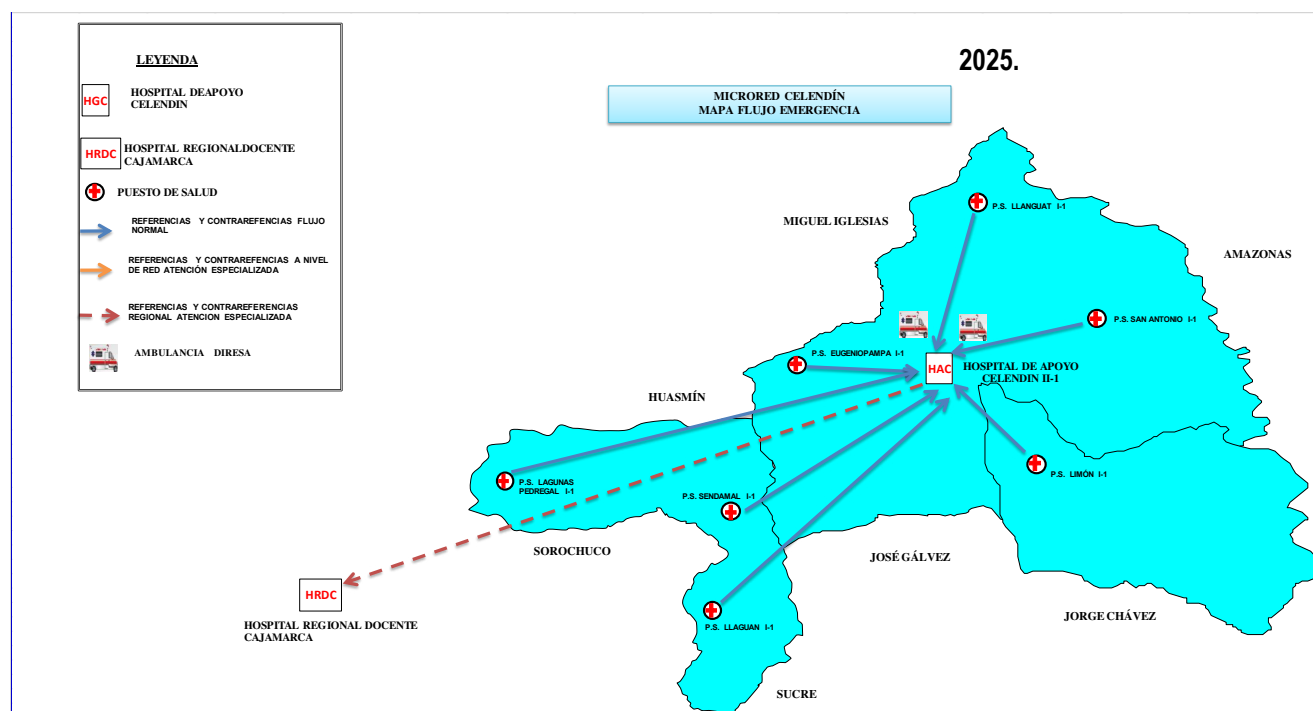
Mapa. Flujo de referencia Microred Sucre de la Provincia de Celendín, 2025.



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred Sucre expone una red asistencial altamente centralizada en el nivel provincial, donde el Centro de Salud Sucre (I-3) funciona como el eje articulador del flujo normal de referencias para los establecimientos periféricos de Oxamarca (I-2), Jorge Chávez (I-1), La Quinua (I-1) y Piobamba (I-2). Ante emergencias de mayor complejidad, la microred activa una robusta red de atención especializada provincial que conecta de manera directa al propio Centro de Salud Sucre y a casi la totalidad de sus puestos dependientes —incluyendo a Fraylecocha (I-1), José Gálvez (I-2), Cruzconga (I-1), Calconga (I-1), Vigaspampa (I-1) y Minasconga, con el Hospital de Apoyo Celendín (HAC); de forma paralela, y apoyados por el soporte de ambulancias de la Diresa y municipales, los establecimientos situados en la franja más occidental (Calconga, Cruzconga, Vigaspampa y Minasconga) disponen de un corredor alternativo de atención especializada regional hacia el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC) para mitigar las barreras de accesibilidad geográfica y asegurar una respuesta médica oportuna.

Mapa. Flujo de referencia Microred Celendín de la Provincia de Celendín,



Fuente. Oficina de Servicio de Salud Red Celendín

La Microred Celendín describe una estructura sanitaria altamente centralizada en el ámbito local, donde el Hospital de Apoyo Celendín (HAC II-1) se consolida como el núcleo receptor absoluto de la red, absorbiendo de manera directa el flujo normal de referencias desde la totalidad de los establecimientos de su jurisdicción, que incluye a los puestos de salud de Languat (I-1), San Antonio (I-1), Limón (I-1), Llaguán (I-1), Sendamal (I-1), Eugeniopampa (I-1) y Lagunas Pedregal (I-1). Para dar soporte a este nivel de demanda, la microred dispone del despliegue estratégico de ambulancias de la DIRESA situadas en el hospital base y en puntos periféricos de enlace; asimismo, ante emergencias críticas que superan la capacidad resolutoria provincial, se establece un corredor prioritario de atención especializada regional sustentado por las unidades de transporte que conecta directamente el eje de evacuación desde el P.S. Lagunas Pedregal (I-1) hacia el Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC), optimizando así la ventana de respuesta médica frente a pacientes de alta complejidad procedentes de la zona occidental.

3.4.4. Recursos Humanos

Número de recurso humano por régimen laboral

CARGO	DL. 276	DL. 1057	LOCACIÓN DE SERVICIOS	TOTAL
Médicos	8	8	1	16
Enfermeros	21	20	2	41
Obstetras	15	6	1	21
Psicólogos	8	4		12
Odontólogos	2	0		2
Químicos	4	4		8
Biólogo	4	4		8
Técnicos	33	21	2	54
Otros	3	3	8	6
Total	4	70	14	168

Fuente. Oficina de Recursos Humanos de la Red de salud Celendín

El distrito de Celendín cuenta con un total de **168 recursos humanos en salud**, distribuidos entre los regímenes laborales del Decreto Legislativo N.° 276, Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS) y personal bajo la modalidad de locación de servicios. La mayor disponibilidad corresponde a técnicos en salud, enfermeros, obstetras y médicos, quienes sostienen la mayor parte de las actividades asistenciales y de salud pública.

Sin embargo, el análisis de la distribución del recurso humano evidencia una limitada disponibilidad de algunos perfiles profesionales indispensables para brindar una atención integral. Destaca la escasa dotación de **odontólogos (2)**, profesionales que cumplen funciones esenciales en salud bucal.

En ese sentido, se considera prioritario fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de salud mediante la contratación de **odontólogos; además de otros profesionales de la salud**, con la finalidad de mejorar la cobertura de los servicios especializados, garantizar una atención integral y responder de manera oportuna a las necesidades de salud de la población del distrito de Celendín

3.4.5. Equipamiento

Equipamiento en el Distrito de Celendín

DISTRITO	N° EE.SS	EQUIPAMIENTO	ESTADO			
			BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL GENERAL
CELENDÍN	5	AMBULANCIA RURAL	1	2		3
		ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO		1		1
		ANALIZADOR DE OXIGENO		1		1
		ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO		1		1
		ASPIRADOR DE SECRECIONES		11	1	12
		AUTOCLAVE		3		3
		BALANZAS	2	35	4	41
		BALON DE OXIGENO DE 10 M3	1	86	1	88
		BIOMBO DE METAL	2	26	2	30
		CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER	2			2
		CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 20 L	1	4		5
		CAMA DE METAL HOSPITALARIA DOS MANIVELAS	1	8	1	10
		CARDIOTOCOGRAFO		1		1
		CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS		3	1	4
		COLESTEROMETRO DIGITAL		2		2
		COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	2			2
		CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMETRO		1		1
		CONGELADORAS	4	5		9
		DENSITOMETRO	1			1
		DERMATOSCOPIO		1		1
		DESFIBRILADOR		3		3
		DETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	6		7
		ECOGRAFO PORTATIL		1		1
		ELECTROCARDIOGRAFO	1	3		4

		EQUIPO DE ANESTESIA		2		2
		EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA		29	1	30
		EQUIPO DE RAYOS X		2		2
		EQUIPO DE RAYOS X DENTAL		1		1
		EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL		1	1	2
		EQUIPO NEBULIZADOR		7		7
		ESTERILIZADOR DE 19 L	1	2	2	5
		EXTINTOR	2	10		12
		FETOSCOPIO		1		1
		GLUCOMETRO PORTATIL		8		8
		HEMOGLOBINOMETRO	2	10	1	13
		HORNO DE ESTERILIZACION EN CALOR SECO		4		4
		INCUBADORA DE CULTIVO DE 53 L	1	3	1	5
		INFANTOMETRO	1	18		19
		LARINGOSCOPIO	1	2		3
		LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO		3	1	4
		MICROCENTRIFUGA	1	1		2
		MICROMOTOR DENTAL		2	1	3
		OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	3	2	2	7
		REFRIGERADORA CONGELADORA ELECTRICA A COMPRESION HORIZONTAL PARA VACUNAS DE 74 L	6	11	3	20
		REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	2	10	2	14
		RESUCITADOR			1	1
		RESUCITADOR MANUAL ADULTO		10	1	11
		RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 300 ML	1			1
		RESUCITADOR NEONATAL		1		1
		SECADORA SEMI INDUSTRIAL PARA ROPA DE 13 KG		1		1
		TABLA ESPINAL		1		1
		TALLIMETRO	2	21	1	24
		TENSIOMETRO	9	42	34	85

		TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS	6	24	1	31
		TERMOMETRO	18	20	1	39
		TURBIDIMETRO DIGITAL		1		1
		TOTAL GENERAL	626	591	96	1313

Fuente. Oficina de Patrimonio de la Red de Salud Celendín

En los establecimientos de salud del distrito de Celendín, registra un total de 1 313 equipos biomédicos y de apoyo asistencial. De este total, 626 equipos (47,7%) se encuentran en buen estado, 591 (45,0%) en estado regular y 96 (7,3%) en mal estado. Estos resultados muestran que la mayor parte del equipamiento se encuentra operativo; sin embargo, una proporción considerable requiere mantenimiento para garantizar su adecuado funcionamiento y disponibilidad durante la prestación de los servicios de salud.

Entre los equipos con mayor cantidad destacan los balones de oxígeno de 10 m³ (88), tensiómetros (85), balanzas (41), termómetros (39), termos para transporte de biológicos y vacunas (31) y equipos de oxigenoterapia (30). Estos equipos son esenciales para las actividades de atención primaria, el monitoreo clínico, la inmunización y la atención de emergencias. Asimismo, se observa que la mayoría de ellos se encuentra en estado regular, lo que evidencia el uso continuo de estos recursos en la atención diaria de la población.

Desde la perspectiva del Análisis de Situación de Salud (ASIS), el estado del equipamiento constituye un factor que influye en la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud. La presencia de equipos en estado regular y malo puede limitar la oportunidad y calidad de la atención, especialmente en los servicios de diagnóstico, tratamiento y atención de emergencias. En este contexto, resulta importante fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición del equipamiento biomédico, con la finalidad de asegurar la continuidad de los servicios y mejorar la capacidad de respuesta de la Red de Salud Celendín frente a las necesidades de salud de la población.

3.4.6. Infraestructura

Infraestructura de los establecimientos de salud en la provincia de Celendín.

DISTRITO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	ESTADO		
		Bueno	Regular	malo
CELENDÍN	5	3	2	
HUASMÍN	9	4	4	1
SOROCHUCO	7	3	4	
SUCRE	4	3	1	
JOSE GALVEZ	2	1	1	
JORGE CHAVEZ	1	1		
OXAMARCA	4	4		
LA LIBERTAD DE PALLAN	3	3		
UTCO LIMON	1		1	
CORTEGANA	7	4	3	
MIGUEL IGLESIAS	5	1	4	
CHUMUCH	2		2	
PROVINCIAL	50	27	22	1

Fuente. Oficina de Patrimonio de la Red de Salud Celendín

La provincia de Celendín cuenta con 50 establecimientos de salud, de los cuales 27 (54%) se encuentran en buen estado, 22 (44%) en estado regular y 1 (2%) en estado malo. Si bien la totalidad de los establecimientos se mantiene operativa, una proporción importante presenta deficiencias en su infraestructura, principalmente por necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, condiciones de contingencia, uso de módulos prefabricados o funcionamiento en locales prestados, situaciones que pueden afectar la calidad, seguridad y oportunidad de la atención de salud.

La mayor parte de las brechas de infraestructura se concentra en los establecimientos clasificados en estado regular, los cuales requieren intervenciones para preservar su capacidad operativa y evitar un mayor deterioro. Asimismo, el Puesto de Salud **Santa Rosa de Huasmín**, único establecimiento catalogado en estado malo, constituye la principal prioridad de intervención debido a las deficientes

condiciones de su infraestructura, las cuales representan un riesgo para la continuidad y calidad de los servicios brindados a la población.

El **Hospital de Apoyo Celendín**, principal establecimiento de referencia de la provincia, se encuentra operativo; no obstante, actualmente funciona en una infraestructura alquilada ya que la infraestructura está en construcción, situación que podría generar restricciones temporales en la prestación de algunos servicios y en las condiciones de atención.

Por otro lado, el Centro de Salud Mental Comunitario de Celendín brinda atención de manera operativa en un local prestado, lo que evidencia la necesidad de contar con una infraestructura propia que garantice la sostenibilidad y expansión de los servicios de salud mental en la provincia.

En este contexto, resulta necesario priorizar la gestión de recursos para el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos de salud, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en estado regular y en el Puesto de Salud Santa Rosa de Huasmin, con el propósito de fortalecer la capacidad resolutive de la red de servicios y garantizar una atención segura, oportuna y de calidad para la población de la provincia de Celendín.

3.4.7. Medicamentos

Disponibilidad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -2025	
	DISPONIBILIDAD
CELENDÍN	91.74
UTCO LIMON	92.17
SUCRE	90.58
OXAMARCA	90.63
JOSÉ GÁLVEZ	90.78
JORGE CHÁVEZ	89.43
HUASMIN	90.23
CORTEGANA	91.08
MIGUEL IGLESIAS	88.61
CHUMUCH	90.68
SOROCHUCO	89.35
LA LIBERTAD DE PALLAN	89.28
RED CELENDIN	90.38

Fuente. Oficina de DIREMID de la Red de Salud Celendín

Durante el año 2025, la Red de Salud Celendín alcanzó una disponibilidad promedio de medicamentos de **90.38%**, evidenciando un abastecimiento favorable en la mayoría de los establecimientos de salud. Los distritos con mayor disponibilidad fueron **Utcó Limón (92.17%)**, **Celendín (91.74%)** y **Cortegana (91.08%)**, lo que refleja una adecuada gestión del suministro y distribución de medicamentos para la atención de la población.

Por otro lado, los distritos de **Miguel Iglesias (88.61%)**, **La Libertad de Pallán (89.28%)**, **Sorochuco (89.35%)** y **Jorge Chávez (89.43%)** presentaron los porcentajes más bajos de disponibilidad, aunque manteniéndose cercanos al 90%. Esta situación podría estar relacionada con dificultades en la reposición oportuna de medicamentos, condiciones geográficas de acceso o variaciones en la demanda de los servicios de salud.

En términos generales, los resultados muestran que la Red de Salud Celendín mantiene una disponibilidad de medicamentos superior al 90%, permitiendo garantizar la continuidad de la atención sanitaria. Sin embargo, es necesario fortalecer las acciones de programación, monitoreo de stocks y abastecimiento oportuno en los establecimientos con menores porcentajes, con el fin de reducir el riesgo de desabastecimiento y mejorar el acceso de la población a los medicamentos esenciales.

3.4.8. Residuos sólidos.

Tabla. Vigilancias sanitarias de gestión y manejo de residuos sólidos según distrito. Provincia de Celendín, 2025

DISTRITO	VIGILANCIAS PROGRAMADAS	GESTIÓN: ACEPTABLE	% GESTIÓN	MANEJO: ACEPTABLE	% MANEJO	CUMPLIMIENTO
CELENDÍN	2	2	100%	2	100%	100%
CHUMUCH	—	—	S/I	—	S/I	S/I
CORTEGANA	2	2	100%	2	100%	100%
HUASMÍN	—	—	S/I	—	S/I	S/I
JORGE CHÁVEZ	—	—	S/I	—	S/I	S/I
JOSÉ GÁLVEZ	1	1	100%	1	100%	100%
LA LIBERTAD DE PALLÁN	1	1	100%	1	100%	100%
MIGUEL IGLESIAS	1	1	100%	1	100%	100%

OXAMARCA	2	2	100%	2	100%	100%
SOROCHUCO	1	1	100%	1	100%	100%
SUCRE	2	2	100%	2	100%	100%
UTCO	1	1	100%	1	100%	100%
TOTAL CON INFORMACIÓN	13	13	100%	13	100%	100%

Fuente. Oficina de Salud Ambiental de la Red de Salud Celendín

Leyenda: S/I = Sin información registrada para el periodo evaluado.

Durante el periodo evaluado, la provincia de Celendín presentó un desempeño favorable en las actividades de vigilancia sanitaria relacionadas con la gestión y manejo de residuos sólidos, evidenciándose un cumplimiento del 100% en los distritos que cuentan con información registrada. De acuerdo con los datos disponibles, se programaron 13 vigilancias sanitarias, correspondientes a los distritos de Celendín, Cortegana, José Gálvez, La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre y Utco. En todos estos distritos, las vigilancias realizadas obtuvieron una valoración aceptable, tanto en el componente de gestión de residuos sólidos como en el componente de manejo de residuos sólidos, alcanzando ambos indicadores un cumplimiento del 100%.

Este resultado evidencia una adecuada ejecución de las actividades de vigilancia sanitaria en los distritos que cuentan con registros, lo cual constituye un aspecto favorable para la salud ambiental de la provincia. La vigilancia de la gestión y manejo de los residuos sólidos permite identificar oportunamente condiciones que podrían generar riesgos para la población, especialmente aquellas relacionadas con la disposición inadecuada de residuos, acumulación de desechos, deficiencias en el almacenamiento, transporte y disposición final, así como otros factores ambientales que pueden favorecer la aparición de enfermedades y afectar las condiciones sanitarias de las comunidades.

A nivel distrital. Celendín, Cortegana, José Gálvez, La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre y Utco alcanzaron el 100% de valoración aceptable en los indicadores evaluados. Esto refleja que, en los establecimientos o ámbitos donde se efectuó la vigilancia y se cuenta con información registrada, las condiciones evaluadas fueron consideradas satisfactorias de acuerdo con los criterios establecidos para los indicadores.

Sin embargo, el análisis provincial también permite identificar una brecha importante relacionada con la disponibilidad y registro de información, debido a que para los distritos de **Chumuch, Huasmín y Jorge Chávez** no se dispone de información registrada en la base de datos utilizada para el presente análisis. Esta situación se considera como una oportunidad de mejora, ya que la ausencia de registros limita la posibilidad de realizar una evaluación integral de la situación sanitaria y ambiental de toda la provincia. Es importante precisar que la falta de información no debe interpretarse como incumplimiento, ausencia de vigilancia ni resultado de 0%, sino como una limitación en la disponibilidad del dato para el periodo evaluado.

En este sentido, resulta necesario fortalecer el proceso de recolección, consolidación, validación y reporte de información en los distritos que presentan ausencia de registros, promoviendo una mayor articulación entre los establecimientos de salud, responsables de salud ambiental y las autoridades locales. Asimismo, se debe garantizar que las actividades de vigilancia sanitaria sean registradas oportunamente y con criterios homogéneos, permitiendo contar con información completa y comparable para futuras evaluaciones.

Desde una perspectiva provincial, el resultado de 100% de cumplimiento en los distritos con información disponible constituye un indicador favorable; no obstante, debe interpretarse considerando la existencia de distritos sin información registrada. Por ello, para fortalecer el análisis situacional de salud, no solo es necesario mantener los niveles de cumplimiento alcanzados, sino también cerrar la brecha de información existente, incorporando progresivamente a todos los distritos de la provincia en el sistema de vigilancia y registro correspondiente.

La provincia presenta un cumplimiento favorable de las vigilancias sanitarias de gestión y manejo de residuos sólidos en los distritos evaluados, pero persiste una brecha de información en Chumuch, Huasmín y Jorge Chávez. El principal reto consiste en garantizar la continuidad de las actividades de vigilancia y mejorar la oportunidad y calidad del registro, de manera que los próximos análisis del ASIS permitan disponer de una visión integral de la situación de salud ambiental de los 12 distritos de la provincia de Celendín.

3.4.9. Sistema de Información

Tabla. Establecimientos de salud según sistema de información utilizado, por distrito. Provincia de Salud Celendín, 2025.

DISTRITO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	ESTADO DE IMPLEMENTACION			SISTEMA QUE UTILIZAN
		ADMISION	CONSULTA EXTERNA	CRED	
CELENDÍN	5	1	1	3	ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV EN LINEA
HUASMÍN	9			9	ONE VISION, REFCON, WAWARED
SOROCHUCO	7		1	6	REFCON, ONE VISION, CNV EN LINEA
SUCRE	4	1		3	ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV EN LINEA, EQALLI
JOSE GALVEZ	2	1		1	REFCON, HSICE
JORGE CHAVEZ	1			1	REFCON
OXAMARCA	4	1		3	REFCON, CNV EN LINEA
LA LIBERTAD DE PALLAN	3	1		2	REFCON, ONE VISION, WAWARED, HSICE, CNV EN LINEA
UTCO LIMON	1			1	REFCON
CORTEGANA	7	1		6	ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV EN LINEA
MIGUEL IGLESIAS	5	1		4	ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV EN LINEA
CHUMUCH	2	1		1	REFCON
PROVINCIAL	50	8	2	40	ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV EN LINEA, EQALLI

Fuente. oficina de OITE red de salud Celendín

En la Provincia de Celendín se cuenta con 50 establecimientos de salud que utilizan sistemas de información para el registro y gestión de la atención sanitaria. Del total, 40 establecimientos (80%) utilizan el sistema en CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo), mientras que 8 establecimientos (16%) cuentan con sistema para Admisión y 2 (4%) para Consulta Externa. Esto evidencia un avance importante en la incorporación de herramientas informáticas para el registro de las prestaciones de salud.

Los Distritos con establecimientos dentro de su jurisdicción utilizan diferentes plataformas, entre ellas **ONE VISION, WAWARED, REFCON, CNV en línea, EQALLI y HSICE**, de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento y servicio. Se observa que **REFCON y ONE VISION** tienen presencia en varios distritos, mientras que otros sistemas presentan una utilización más específica. Esta diversidad permite atender diferentes procesos de información, aunque también puede generar dispersión de los registros y dificultades para integrar la información de manera uniforme.

La provincia de Celendín presenta un nivel significativo de implementación de sistemas de información, principalmente en el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil. Sin embargo, existe la necesidad de fortalecer la implementación de sistemas para Admisión y Consulta Externa, así como mejorar la interoperabilidad, capacitación del personal y calidad del registro, con el propósito de disponer de información oportuna, completa y confiable para la toma de decisiones y planificación de las intervenciones sanitarias en la provincia de Celendín.

4. ANÁLISIS DE ESTADO DE SALUD

4.1. Morbilidad

Tabla. Morbilidad general de la provincia de Celendín año 2025

Grupo Enfermedad	N°	F	M	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	36891	21519	15372	24%
Caries dental	15380	8894	6486	10%
Desnutrición	9181	6369	2812	6%
Lumbago y otras dorsalgias	8070	5033	3037	5%
Obesidad	7670	6268	1402	5%
Gastritis y duodenitis	6463	4224	2239	4%
Infección de vías urinarias	5719	4562	1157	4%
Contractura muscular	4198	2660	1538	3%
Otras enfermedades dentales	3974	2522	1452	3%
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	3326	2206	1120	2%
Otras Enfermedades	51 352	32 829	18523	34%
Total	152 224	97 086	55 138	100%

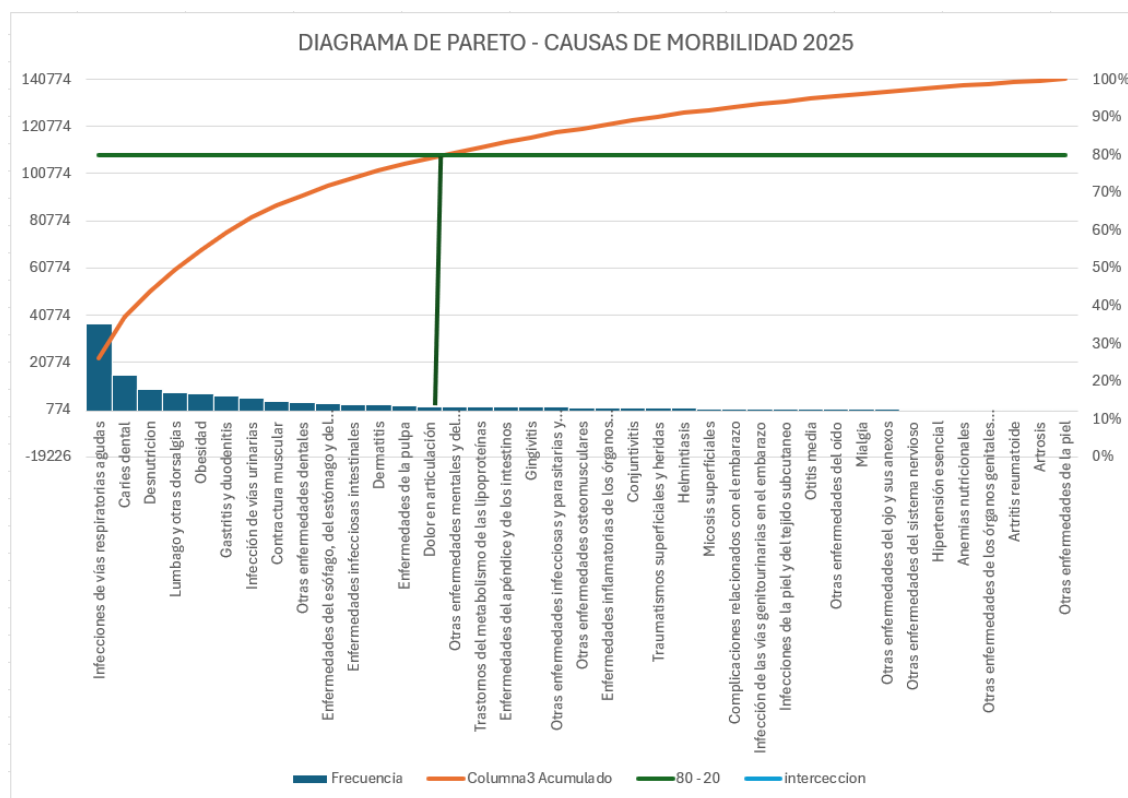
Fuente: HIS-MINSA. Procesamiento: OITE-DIRESA Cajamarca.

Elaboración: ORE-DIRESA Cajamarca

Durante el año 2025 se registraron 152 224 atenciones por morbilidad en la provincia de Celendín, observándose un mayor número de casos en el sexo femenino (97 086 casos; 64%) en comparación con el sexo masculino (55 138 casos; 36%).

La principal causa de morbilidad fueron las Infecciones de Vías Respiratorias Agudas (IRAS) con 36 891 casos (24%), lo que evidencia una alta frecuencia de enfermedades respiratorias asociadas a factores climáticos, cambios bruscos de temperatura, hacinamiento y limitada adopción de medidas preventivas. En segundo lugar, se ubicó la caries dental con 15 380 casos (10%), reflejando deficiencias en hábitos de higiene bucal y acceso oportuno a actividades preventivas.

Asimismo, destacan los casos de desnutrición con 9 181 casos (6%), situación que podría estar relacionada con inadecuadas prácticas alimentarias y condiciones socioeconómicas desfavorables. También se registraron casos importantes de lumbago y otras dorsalgias (5%) y obesidad (5%), asociados a estilos de vida poco saludables, sedentarismo y factores ocupacionales.



Fuente: HIS-MINSA. Procesamiento: OITE-DIRESA Cajamarca.

Elaboración: ORE-DIRESA Cajamarca

El presente diagrama de Pareto muestra que un reducido grupo de enfermedades concentra la mayor carga de morbilidad en la provincia de Celendín durante el año 2025. Las Infecciones de Vías Respiratorias Agudas (IRAS) constituyen la principal

causa de atención, seguidas por caries dental, desnutrición, obesidad, lumbago y otras dorsalgias, gastritis y duodenitis e infecciones de vías urinarias.

Asimismo, se observa que aproximadamente el 80% de los casos acumulados de morbilidad se concentra en un número limitado de causas, lo que evidencia que estas patologías representan los principales problemas de salud de la población y deben ser priorizadas en las intervenciones sanitarias.

Esta situación está relacionada con factores ambientales, hábitos inadecuados de higiene y alimentación, condiciones socioeconómicas desfavorables, estilos de vida poco saludables y limitada adopción de medidas preventivas. Por ello, es necesario fortalecer las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral, enfocando los recursos en las causas que generan la mayor carga de enfermedad en la provincia.

4.2. Mortalidad

Tabla. Mortalidad general de la provincia de Celendín año 2025.

Grupo Enfermedad	N°	F	M	%
Infecciones respiratorias agudas bajas	49	18	31	13%
Enfermedades hipertensivas	16	6	10	4%
Enfermedades isquémicas del corazón	16	13	3	4%
Las demás causas externas	12	1	11	3%
Insuficiencia cardíaca	11	5	6	3%
Insuficiencia renal, incluye, incluye la aguda, crónica y la no especificadas	11	5	6	3%
Infecciones respiratorias agudas bajas	10	6	4	3%
Neoplasia maligna de ojo, encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	9	5	4	2%
Infecciones respiratorias agudas bajas	9	3	6	2%
Enfermedades isquémicas del corazón	8	5	3	2%
Resto de enfermedades	232	108	124	38%
Total	615	175	208	100%

Fuente: SINADEF. Procesamiento: OITE-DIRESA Cajamarca.

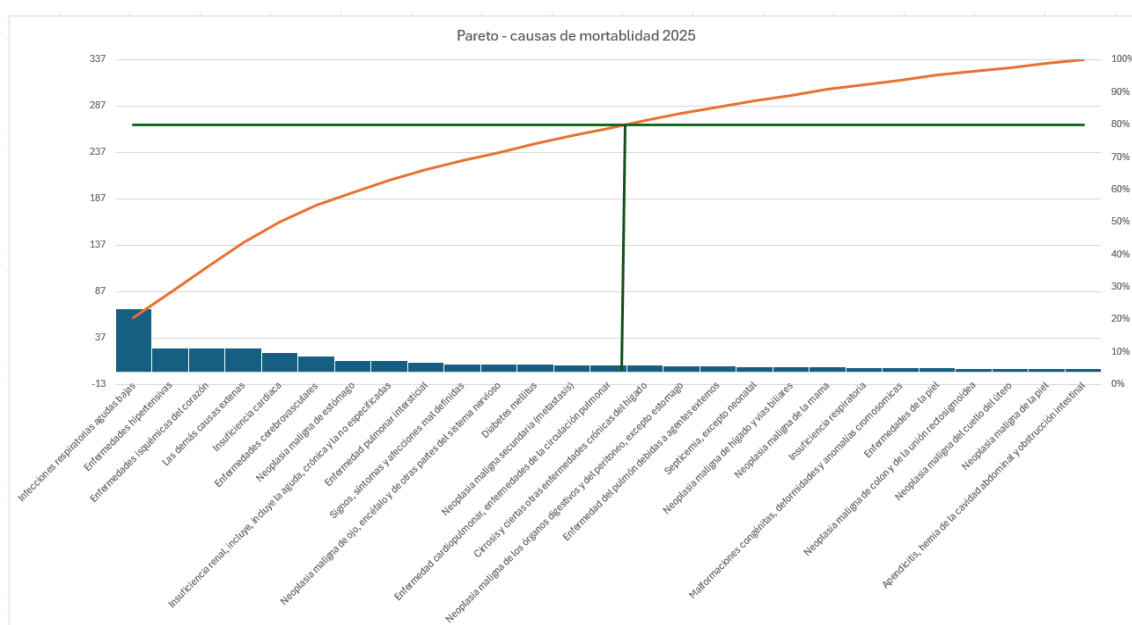
Elaboración: ORE-DIRESA Cajamarca

La mortalidad general en la provincia de Celendín durante el año 2025 se encuentra principalmente determinada por las infecciones respiratorias agudas bajas, las cuales representan la mayor proporción de defunciones (13%). Esta situación se explica por la alta vulnerabilidad de la población, especialmente niños y adultos mayores, la exposición a factores ambientales como el frío, así como el acceso tardío a los servicios de salud y limitadas acciones preventivas en la comunidad.

Asimismo, se observa una importante carga de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente las enfermedades hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal, que en conjunto representan una proporción significativa de las defunciones. Estas causas están relacionadas con estilos de vida poco saludables, como dietas inadecuadas, sedentarismo, falta de control médico y baja adherencia a los tratamientos.

Por otro lado, las causas externas y las neoplasias malignas presentan menor proporción, aunque siguen siendo relevantes dentro del perfil de mortalidad. Finalmente, el alto porcentaje del grupo “resto de enfermedades” evidencia limitaciones en la especificación y registro adecuado de las causas de defunción, lo que dificulta un análisis más preciso y puede reflejar debilidades en la calidad del sistema de información en salud.

Figura. Diagrama de Pareto de las principales causas de mortalidad en la provincia de Celendín, 2025



Fuente: SINADEF. Procesamiento: OITE–DIRESA Cajamarca.

Elaboración: ORE–DIRESA Cajamarca

El gráfico de Pareto de la mortalidad en la provincia de Celendín 2025 muestra que la mayor concentración de defunciones se explica por un número reducido de causas principales, lo que evidencia un patrón típico de “concentración del problema” en salud pública.

Se observa que las infecciones respiratorias agudas bajas son la causa predominante de mortalidad, seguida por las enfermedades cardiovasculares (como hipertensión, enfermedades isquémicas del corazón e insuficiencia cardíaca), además de un grupo importante de causas externas y otras causas mal definidas. Estas pocas causas concentran la mayor parte de las defunciones, alcanzando aproximadamente el 80% acumulado según el análisis de Pareto.

Esto indica que la mortalidad en la provincia no se distribuye de manera homogénea, sino que está concentrada en problemas prioritarios y en su mayoría prevenibles o controlables. En particular, las infecciones respiratorias reflejan vulnerabilidad poblacional y factores ambientales, mientras que las enfermedades cardiovasculares están asociadas a estilos de vida no saludables, baja adherencia al tratamiento y diagnóstico tardío.

4.3. Vigilancia Epidemiológica.

El comportamiento de las enfermedades y daños sujetos a vigilancia en salud pública en la provincia de Celendín evidencia la presencia de eventos transmisibles y no transmisibles que requieren vigilancia epidemiológica permanente. La distribución de los casos presenta diferencias importantes entre los distritos, observándose algunos territorios con mayor concentración de casos y otros con mayores razones de episodios en relación con su población. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna, el seguimiento de casos y la implementación de medidas de prevención y control de acuerdo con las características de cada territorio.

4.3.1. VIH

Durante el periodo evaluado se registraron **15 casos de VIH** en la provincia de Celendín. La mayor concentración se presenta en el distrito de **Celendín, con 9 casos (60,0%)**, seguido de **Cortegana con 4 casos (26,7%)**. Asimismo, **Huasmín y José Gálvez registraron 1 caso cada uno (6,7%)**. En conjunto, los distritos de

Celendín y Cortegana concentran el **86,7% de los casos registrados**, constituyéndose en los territorios con mayor concentración del evento.

La concentración de casos en estos dos distritos evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y diagnóstico oportuno, así como la consejería, acceso a pruebas de VIH, vinculación de las personas diagnosticadas a los servicios de salud y seguimiento correspondiente. Asimismo, las actividades preventivas deben orientarse a reducir los factores de riesgo y favorecer el diagnóstico temprano, garantizando la confidencialidad y atención integral de las personas afectadas.

4.3.2. TUBERCULOSIS

En la Provincia de Celendín se registraron **4 casos de tuberculosis**, de los cuales **2 corresponden a tuberculosis sensible, 1 a tuberculosis sensible de localización meníngea y 1 caso de tuberculosis pre-XDR**. Los casos se concentran en los distritos de **Celendín, Utco y Chumuch**.

La presencia de tuberculosis meníngea y de un caso pre-XDR constituye un aspecto de especial importancia para la vigilancia epidemiológica, debido a la complejidad de estos casos y al riesgo asociado a la resistencia a los medicamentos. En este contexto, es necesario fortalecer la búsqueda y diagnóstico oportuno de casos, seguimiento del tratamiento, vigilancia de la adherencia, estudio de contactos y seguimiento de los pacientes hasta su condición final. La vigilancia debe mantenerse especialmente en los distritos donde se han identificado casos, con énfasis en la identificación de nuevos casos y contactos.

4.3.3. LEISHMANIASIS

La leishmaniasis presenta una distribución territorial importante en la provincia de Celendín. Según el reporte de casos por distrito correspondiente al año 2025, se registraron **26 casos**, concentrándose principalmente en **Cortegana con 7 casos, Celendín con 6 casos, Huasmín con 5 casos y Chumuch con 4 casos**. Asimismo, se registró **1 caso en cada uno de los distritos de Utco, Sorochuco, Oxamarca y Miguel Iglesias**.

Los cuatro distritos con mayor número de casos: Cortegana, Celendín, Huasmín y Chumuch, concentran la mayor parte de los casos registrados, por lo que deben ser considerados prioritarios para las acciones de vigilancia y control. La presencia de casos en varios distritos demuestra que el evento tiene una distribución territorial

amplia dentro de la provincia. Por ello, se requiere fortalecer la búsqueda activa y pasiva de casos, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, seguimiento de pacientes y actividades de prevención y control, especialmente en las zonas donde existe mayor concentración de casos.

4.3.4. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

Las enfermedades diarreicas agudas constituyen un importante evento de vigilancia epidemiológica en la provincia. Para el año 2025, la **razón provincial fue de 12,89 episodios por 1 000 habitantes**, observándose diferencias importantes entre los distritos.

El distrito de **Cortegana presentó la mayor razón, con 37,86 episodios por 1 000 habitantes**, seguido de José Gálvez, Sucre y Chumuch, cuyos valores también se encuentran por encima de la razón provincial. Asimismo, Miguel Iglesias y Oxamarca presentan valores superiores al promedio provincial. En contraste, Huasmín, Sorochocho, Utco, Celendín y La Libertad de Pallán presentan razones inferiores a la razón provincial, mientras que Jorge Chávez registra el valor más bajo.

El comportamiento observado evidencia una mayor ocurrencia relativa de EDA en determinados distritos, especialmente Cortegana. Por ello, es necesario fortalecer la vigilancia de estos eventos, identificar oportunamente incrementos inusuales de casos y reforzar las intervenciones relacionadas con consumo de **agua segura**, higiene de manos, adecuada manipulación de alimentos, saneamiento básico y educación sanitaria. Asimismo, debe mantenerse la vigilancia para detectar oportunamente posibles brotes o incrementos de casos.

4.3.5. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

Las infecciones respiratorias agudas constituyen otro de los principales eventos sujetos a vigilancia en la provincia. Para el año 2025, la **razón provincial fue de 4 883,03 episodios por 10 000 habitantes**, observándose una marcada variabilidad entre los distritos.

Cortegana presentó la mayor razón provincial, con 11 175,55 episodios por 10 000 habitantes, seguido de Miguel Iglesias y Huasmín. También se observaron valores superiores al promedio provincial en José Gálvez, La Libertad de Pallán, Utco y Sucre. Sorochocho presenta una razón cercana al promedio provincial,

mientras que Chumuch, Oxamarca, Celendín y Jorge Chávez registran valores inferiores.

La elevada razón observada en Cortegana y en otros distritos evidencia la necesidad de mantener una vigilancia activa de las IRA, especialmente para identificar oportunamente casos que puedan evolucionar hacia complicaciones. Las intervenciones deben incluir educación a la población sobre signos de alarma, atención oportuna, seguimiento de población vulnerable y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. Asimismo, es importante analizar periódicamente la tendencia de estos eventos para identificar incrementos inusuales

4.3.6. CÁNCER

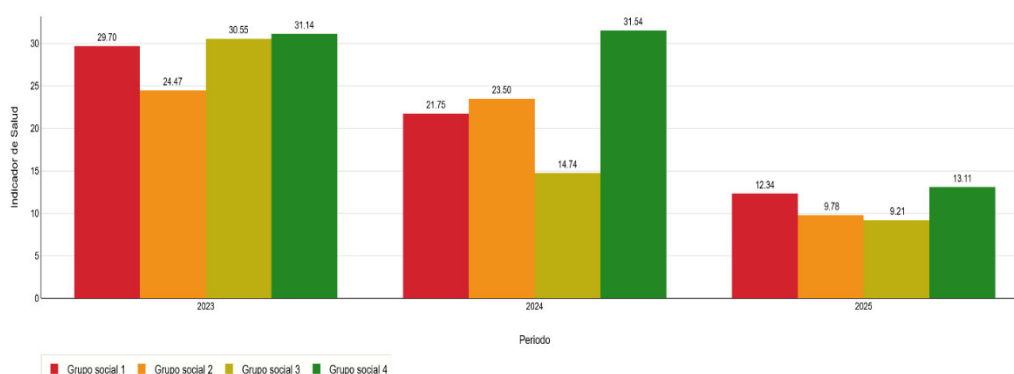
En relación con las enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia, durante el periodo evaluado se registraron **53 casos de cáncer en toda la provincia de Celendín**. La presencia de estos casos evidencia la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica del cáncer, promoviendo el diagnóstico oportuno y el seguimiento de las personas afectadas. Asimismo, resulta necesario fortalecer las actividades de prevención, promoción de estilos de vida saludables y tamizaje de los principales tipos de cáncer de acuerdo con las estrategias y normas vigentes. El registro y actualización permanente de los casos permitirá mejorar la caracterización del problema y orientar las intervenciones hacia los grupos y territorios con mayor necesidad.

4.3.7. DIABETES MELLITUS

En la provincia de Celendín se registraron **243 casos de diabetes mellitus**. La presencia de estos casos refleja la importancia que tienen las enfermedades no transmisibles dentro de la carga de enfermedad de la provincia. El abordaje requiere fortalecer la detección oportuna, control periódico, seguimiento de los pacientes, adherencia al tratamiento y educación para el autocuidado. Asimismo, es fundamental promover alimentación saludable, actividad física y control de factores de riesgo, con énfasis en la prevención de complicaciones y en el seguimiento continuo de las personas con diagnóstico de diabetes.

4.3.8. ANEMIA

Gradientes de Indicador de Salud por grupos de Estratificador de Equidad



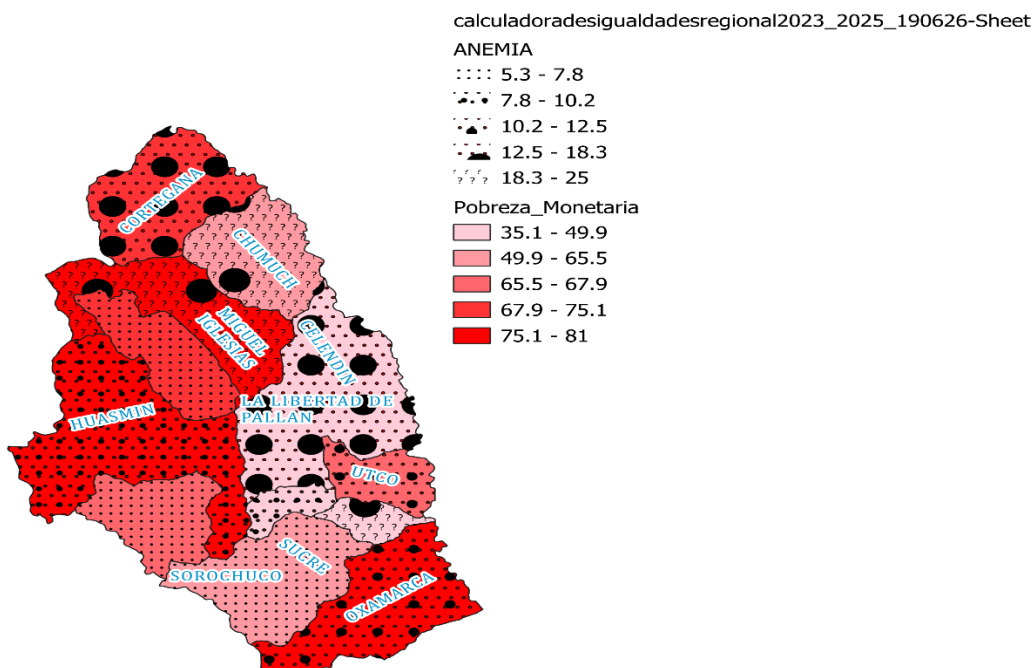
El análisis del gradiente de equidad evidencia que la prevalencia de anemia presenta una **tendencia descendente en todos los grupos sociales entre los años 2023 y 2025**, lo que refleja un avance favorable en las intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento implementadas en el ámbito de la Red de Salud Celendín.

En el año **2023**, la prevalencia de anemia fue elevada en todos los grupos sociales, con valores que oscilaron entre **24,47 % y 31,14 %**, observándose las mayores prevalencias en los grupos sociales 3 y 4. Para el **2024**, se aprecia una disminución importante en los grupos sociales 1 y 3; sin embargo, el grupo social 4 mantuvo una prevalencia elevada (**31,54 %**), lo que evidencia la persistencia de desigualdades relacionadas con factores sociales, económicos y de acceso a los servicios de salud.

En **2025**, todos los grupos sociales muestran una reducción considerable de la prevalencia de anemia, alcanzando valores entre **9,21 % y 13,11 %**. No obstante, el grupo social 4 continúa registrando el mayor indicador (**13,11 %**), mientras que el grupo social 3 presenta la menor prevalencia (**9,21 %**). Aunque la brecha entre grupos se ha reducido respecto a los años anteriores, aún persisten diferencias que reflejan inequidades en las condiciones de vida, la seguridad alimentaria, el acceso oportuno a los servicios de salud, la adherencia a la suplementación con hierro y las prácticas de alimentación infantil.

Estos resultados indican que las estrategias implementadas han contribuido a disminuir la carga de anemia; sin embargo, es necesario fortalecer las intervenciones dirigidas a los grupos sociales más vulnerables, priorizando acciones

integrales de promoción de la salud, vigilancia nutricional, suplementación preventiva, educación alimentaria y articulación intersectorial, con el propósito de reducir las desigualdades sociales y avanzar hacia una mayor equidad en los resultados de salud.



El análisis espacial evidencia una relación entre la distribución de la anemia y los niveles de pobreza monetaria en los distritos de la provincia de Celendín. Se observa que los distritos con **mayores niveles de pobreza** presentan, en general, una mayor concentración de anemia, lo que refleja la influencia de las condiciones socioeconómicas sobre el estado nutricional de la población, especialmente en niños menores de cinco años.

Los distritos de **Huasmín, Miguel Iglesias, Oxamarca y parte de Cortegana** se ubican entre los niveles más altos de pobreza monetaria, constituyéndose en territorios prioritarios para la implementación de intervenciones integrales, debido a que la pobreza limita el acceso a una alimentación adecuada, agua segura, saneamiento básico, educación nutricional y servicios de salud oportunos.

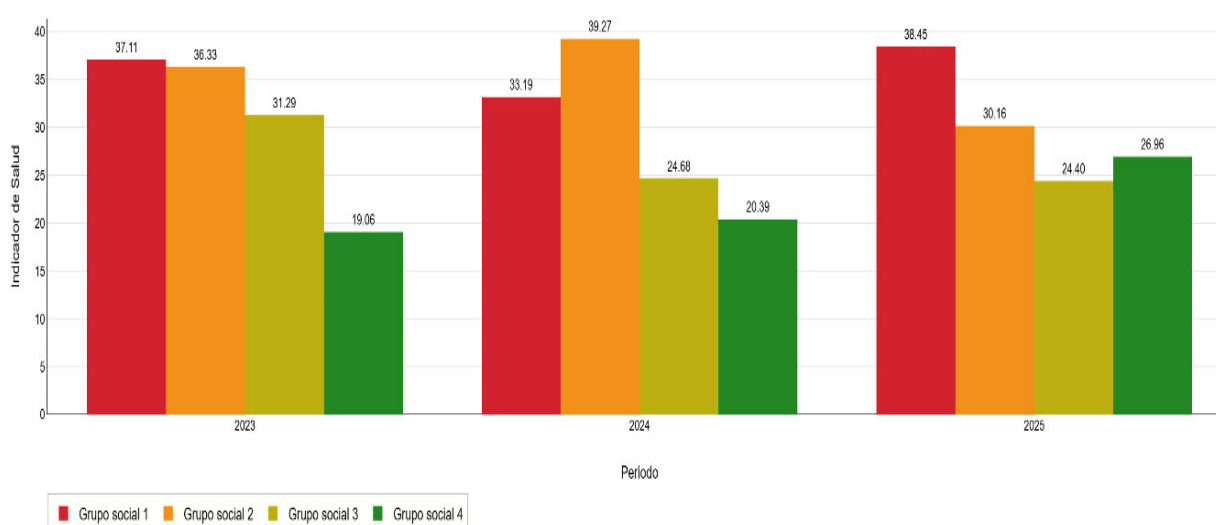
Por otro lado, distritos como **Celendín, Sucre, Utco, José Gálvez y Chumuch** presentan menores niveles relativos de pobreza; sin embargo, aún registran presencia de anemia, lo que evidencia que este problema de salud también está

condicionado por otros determinantes sociales, como las prácticas de alimentación infantil, la adherencia a la suplementación con hierro, la calidad de la atención prenatal y del control de crecimiento y desarrollo, así como factores culturales y geográficos.

En conjunto, el mapa muestra que la anemia mantiene una distribución heterogénea en la provincia y que la pobreza monetaria constituye un importante determinante social asociado a este problema. En ese contexto, resulta necesario fortalecer intervenciones focalizadas en los distritos de mayor vulnerabilidad, promoviendo el trabajo articulado entre el sector salud, gobiernos locales y otros sectores, con énfasis en la reducción de las brechas sociales, el acceso equitativo a los servicios de salud y la mejora de las condiciones de vida de la población.

4.3.9. DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL (DCI)

Gradientes de Indicador de Salud por grupos de Estratificador de Equidad



El análisis del gradiente de equidad para la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) evidencia que este problema continúa afectando de manera diferenciada a los distintos grupos sociales durante el periodo 2023–2025, mostrando variaciones importantes entre ellos que reflejan la influencia de los determinantes sociales de la salud.

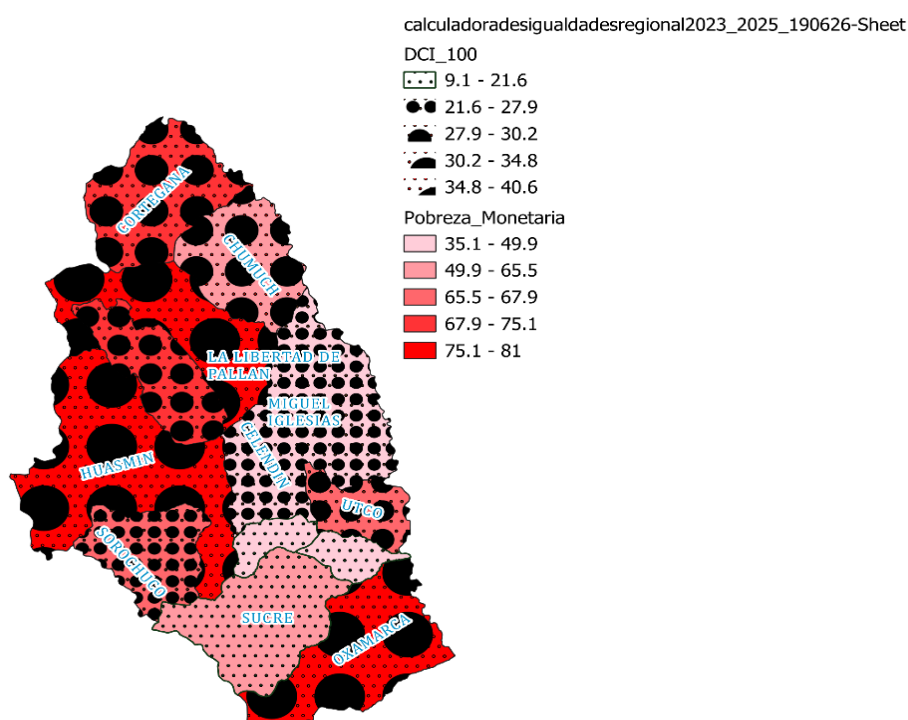
En el año **2023**, los grupos sociales 1 y 2 registraron las mayores prevalencias de DCI, con **37,11 %** y **36,33 %**, respectivamente, mientras que el grupo social 4 presentó el menor valor (**19,06 %**). Durante el **2024**, se observó un incremento de la DCI en el grupo social 2, alcanzando **39,27 %**, constituyéndose en el grupo con

mayor afectación, mientras que los grupos 3 y 4 mantuvieron prevalencias inferiores (24,68 % y 20,39 %, respectivamente).

Para el 2025, la DCI continúa siendo elevada en el grupo social 1 (38,45 %), seguido del grupo social 2 (30,16 %), mientras que los grupos sociales 3 y 4 registraron prevalencias de 24,40 % y 26,96 %, respectivamente. Si bien algunos grupos muestran una reducción respecto a años anteriores, persisten diferencias importantes entre los estratos sociales, evidenciando que la desnutrición crónica infantil continúa asociada a condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Las diferencias observadas entre los grupos sociales reflejan la influencia de factores como la pobreza, la inseguridad alimentaria, el limitado acceso a agua segura y saneamiento, las prácticas inadecuadas de alimentación infantil, el bajo nivel educativo de los cuidadores y las dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud y a las intervenciones de promoción y prevención.

En este contexto, resulta prioritario fortalecer las intervenciones dirigidas a los grupos con mayor vulnerabilidad mediante acciones integrales que incluyan el control prenatal, la promoción de la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria adecuada, el monitoreo del crecimiento y desarrollo, la suplementación con micronutrientes, el acceso a agua segura y saneamiento básico, así como la articulación intersectorial para disminuir las brechas de



inequidad y contribuir a la reducción sostenible de la Desnutrición Crónica Infantil en la provincia de Celendín.

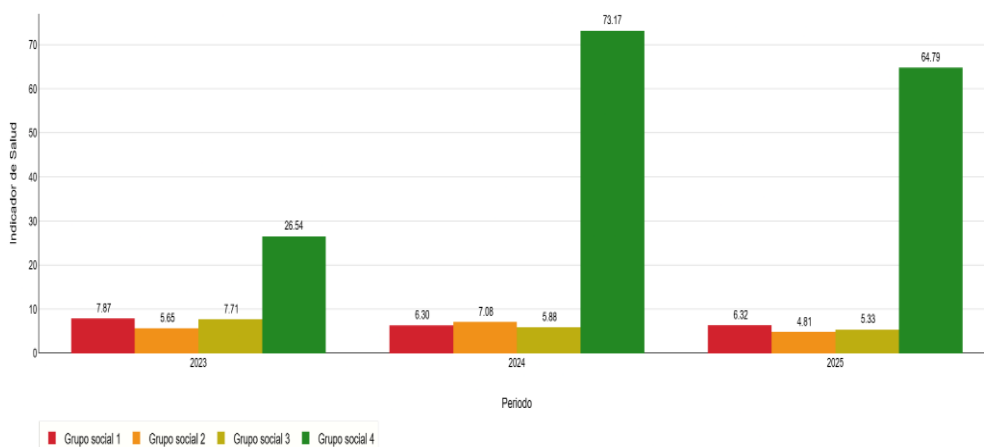
Los distritos de **Cortegana, Huasmín, Sorochuco y Oxamarca** se ubican en los rangos más críticos de pobreza monetaria (entre 67.9% y 81.0%) y, simultáneamente, muestran los patrones de puntos negros más densos, correspondientes a los niveles más altos del DCI_100 (entre 34.8 y 40.6). Este solapamiento territorial consolida a estos distritos como áreas de extrema vulnerabilidad y de máxima prioridad, donde las carencias materiales limitan severamente el desarrollo infantil, la seguridad alimentaria y la capacidad resolutive familiar frente a riesgos sanitarios.

En contraste, distritos como **Celendín, Sucre y Utco** se sitúan en los niveles más bajos de pobreza monetaria relativa (entre 35.1% y 49.9%) y muestran una menor densidad de puntos de desigualdad. No obstante, la persistencia de tramas punteadas en distritos intermedios como **Chumuch, La Libertad de Pallán y Miguel Iglesias** demuestra que la desigualdad regional sigue siendo un desafío vigente en toda la provincia. Esto evidencia que, más allá del ingreso económico directo, existen barreras geográficas, culturales y de infraestructura que perpetúan las brechas en las comunidades rurales.

En conjunto, el análisis espacial revela una distribución heterogénea pero fuertemente vinculada entre la pobreza y las brechas del desarrollo regional. En el contexto de este ASIS 2025, estos hallazgos justifican la urgencia de diseñar e implementar políticas públicas territorializadas. Es imperativo orientar presupuestos y programas sociales con un enfoque de equidad, priorizando los distritos del bloque norte y suroeste para romper el círculo vicioso entre la exclusión socioeconómica y los deficientes indicadores de salud en la provincia.

4.3.10. DIABETES

Gradientes de Indicador de Salud por grupos de Estratificador de Equidad

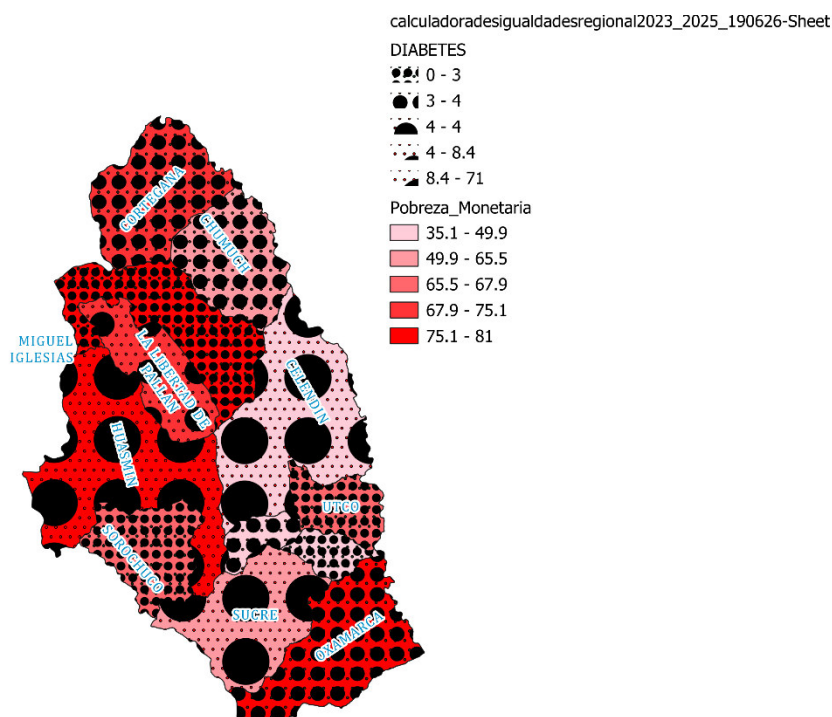


El comportamiento del indicador de diabetes según los grupos del estratificador de equidad durante el período 2023–2025 evidencia una marcada desigualdad en su distribución. Mientras los grupos sociales 1, 2 y 3 mantuvieron valores relativamente bajos y con escasas variaciones (entre 4,81 y 7,87), el Grupo social 4 presentó cifras considerablemente más elevadas, pasando de 26,54 en 2023 a 73,17 en 2024, con una ligera disminución a 64,79 en 2025. Este patrón demuestra que la carga de la enfermedad no se distribuye de manera homogénea en la población, sino que se concentra en un grupo con mayores condiciones de vulnerabilidad.

La persistencia de esta brecha sugiere que el comportamiento del indicador está influenciado por diversos determinantes sociales de la salud, como las condiciones socioeconómicas, el acceso limitado a los servicios de salud, las dificultades para el diagnóstico y seguimiento oportuno, así como una mayor exposición a factores de riesgo, entre ellos la alimentación no saludable, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. El incremento observado en el Grupo social 4 durante 2024 podría reflejar tanto una mayor captación de casos por el fortalecimiento de las actividades de tamizaje como un incremento real de la enfermedad, mientras que la reducción registrada en 2025, aunque significativa, no modifica la amplia brecha existente respecto a los demás grupos.

El análisis de estos resultados evidencia la necesidad de fortalecer las intervenciones sanitarias dirigidas al Grupo social 4, priorizando acciones integrales de promoción de estilos de vida saludables, prevención de factores de riesgo, tamizaje oportuno, diagnóstico precoz y seguimiento continuo de las personas con diabetes. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la capacidad resolutoria de los

establecimientos de salud y promover intervenciones intersectoriales orientadas a reducir las desigualdades asociadas a los determinantes sociales, contribuyendo de esta manera a disminuir las brechas de equidad y mejorar el estado de salud de la población.



El análisis espacial del indicador de diabetes en la provincia de Celendín evidencia una distribución heterogénea entre sus distritos. El mapa muestra diferencias tanto en la magnitud del indicador de diabetes, representada por el tamaño de los círculos negros, como en los niveles de pobreza monetaria, expresados mediante la intensidad de la coloración. Distritos como Celendín, Huasmin, Miguel Iglesias, Surochuco, Oxamarca y Cortegana presentan una mayor carga del indicador, mientras que otros, como Sucre, Utcu y Chumuch, registran valores relativamente menores, lo que refleja una distribución desigual del evento dentro de la provincia.

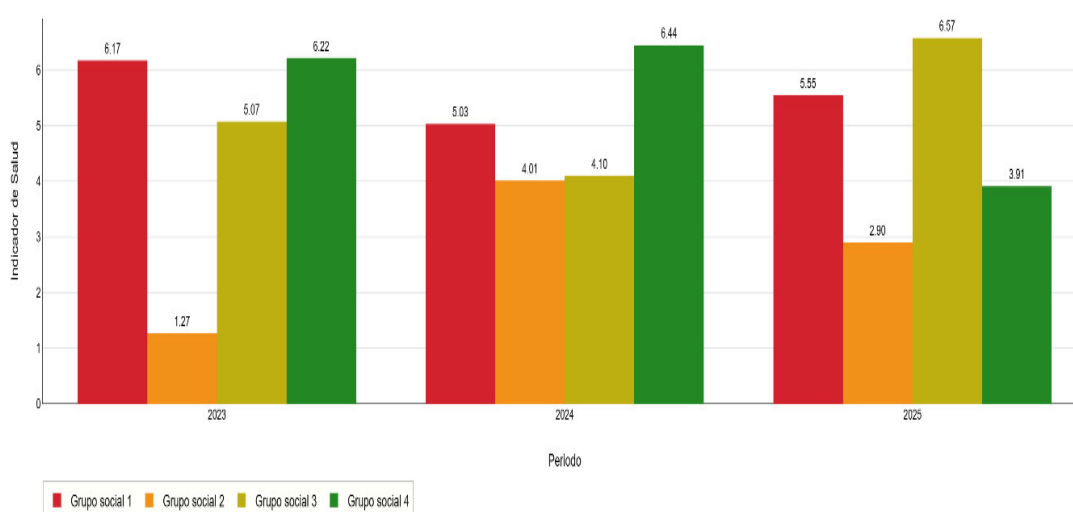
Asimismo, se observa que varios distritos con niveles altos de pobreza monetaria también concentran una mayor magnitud del indicador de diabetes, aunque esta distribución no es uniforme en todo el territorio. Distritos como Huasmin, Surochuco y Oxamarca presentan simultáneamente niveles elevados de pobreza y una mayor carga del indicador, mientras que en otros distritos esta relación es menos evidente. Estos resultados sugieren que, además de las condiciones socioeconómicas, la ocurrencia de la diabetes puede estar influenciada por otros determinantes, como

las características demográficas, los estilos de vida, la accesibilidad a los servicios de salud, la oportunidad del diagnóstico y la capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios.

Los hallazgos permiten identificar áreas prioritarias para la planificación de intervenciones en salud pública, orientadas a fortalecer la prevención, el tamizaje, el diagnóstico oportuno y el seguimiento de las personas con diabetes, especialmente en los distritos que presentan mayor carga del indicador. Del mismo modo, se recomienda complementar este análisis con la evaluación de otros determinantes sociales y sanitarios, a fin de orientar la asignación de recursos y el diseño de estrategias diferenciadas que contribuyan a reducir las desigualdades en salud dentro de la provincia de Celendín.

4.3.11. HIPERTENSIÓN

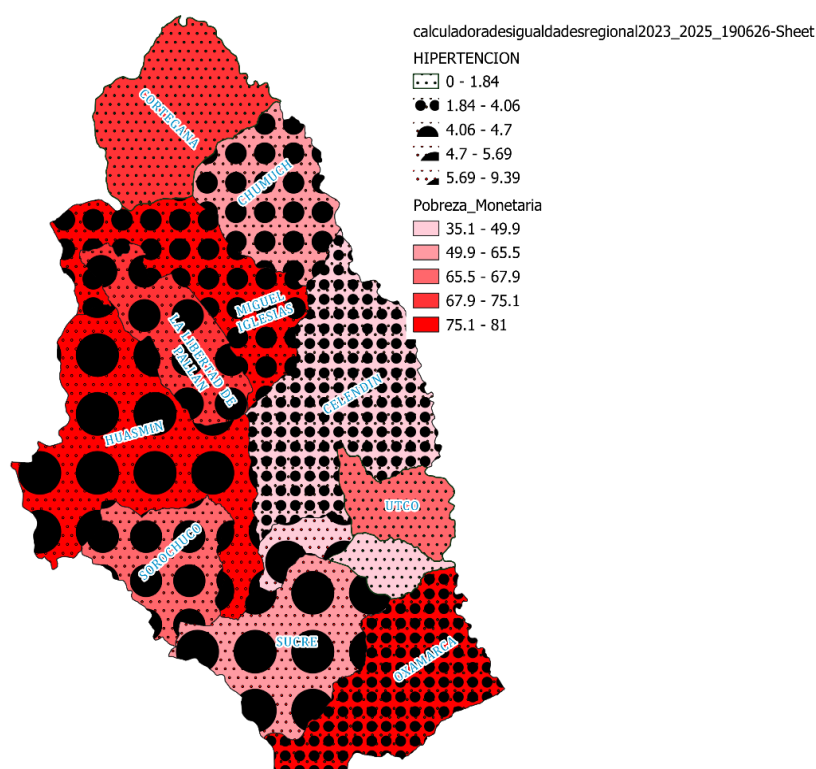
Gradientes de Indicador de Salud por grupos de Estratificador de Equidad



El comportamiento de la prevalencia de hipertensión arterial según los grupos del estratificador de equidad muestra diferencias importantes durante el período 2023–2025. En 2023, los valores más altos correspondieron al Grupo social 4 (6,22) y al Grupo social 1 (6,17), mientras que el Grupo social 2 presentó la menor prevalencia (1,27). En 2024, el Grupo social 4 incrementó ligeramente su valor hasta 6,44, manteniéndose como el grupo con mayor prevalencia, mientras que los grupos 1, 2 y 3 registraron 5,03, 4,01 y 4,10, respectivamente. Para 2025, el Grupo social 3 alcanzó la mayor prevalencia (6,57), seguido del Grupo social 1 (5,55), en tanto que los grupos 2 y 4 registraron 2,90 y 3,91, respectivamente.

Las variaciones observadas entre los grupos sociales evidencian la existencia de desigualdades en la distribución de la hipertensión arterial. El cambio en los grupos con mayor prevalencia a lo largo del período sugiere que la carga de esta enfermedad crónica responde a múltiples determinantes, entre ellos el envejecimiento poblacional, los estilos de vida poco saludables, la alimentación con alto contenido de sodio, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, así como las diferencias en el acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y control oportuno. Estas variaciones también podrían estar influenciadas por una mayor captación de casos y el fortalecimiento de las actividades de tamizaje en determinados grupos poblacionales.

El análisis de estos resultados pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las intervenciones de prevención y control de la hipertensión arterial, priorizando los grupos sociales que presentan las mayores prevalencias del indicador. En este contexto, es fundamental reforzar las acciones de promoción de estilos de vida saludables, detección temprana, seguimiento clínico y adherencia al tratamiento, además de fortalecer la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud para el manejo integral de las enfermedades no transmisibles. Estas intervenciones contribuirán a reducir las desigualdades entre los grupos sociales y a disminuir la carga de la hipertensión arterial en la provincia de Celendín.



El análisis espacial de la hipertensión arterial en la provincia de Celendín evidencia una distribución heterogénea entre sus distritos, observándose diferencias en la magnitud del indicador y en los niveles de pobreza monetaria. El tamaño de los círculos negros representa la prevalencia de hipertensión, mientras que la intensidad de la coloración indica el nivel de pobreza monetaria. Se observa una mayor carga del indicador en distritos como Huasmín, La Libertad de Pallán, Sorochuco, Sucre y Miguel Iglesias, mientras que Chumuch, Celendín, Utco y Cortegana presentan una menor magnitud relativa del evento.

Asimismo, el mapa muestra que algunos distritos con mayores niveles de pobreza monetaria presentan también una elevada prevalencia de hipertensión arterial, particularmente Huasmín, La Libertad de Pallán y Oxamarca. Sin embargo, esta relación no es uniforme en todo el territorio provincial, ya que existen distritos con menor nivel de pobreza que también registran una importante carga de la enfermedad. Este comportamiento evidencia que la hipertensión arterial está influenciada no solo por factores socioeconómicos, sino también por otros determinantes, como el envejecimiento de la población, los hábitos alimentarios, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el acceso a los servicios de salud y la oportunidad del diagnóstico y tratamiento.

Estos hallazgos permiten identificar distritos prioritarios para fortalecer las intervenciones de prevención y control de la hipertensión arterial. En este contexto, resulta necesario reforzar las acciones de promoción de estilos de vida saludables, el tamizaje oportuno, el diagnóstico precoz, el seguimiento de las personas con hipertensión y la adherencia al tratamiento, especialmente en los distritos con mayor carga del indicador. Asimismo, se recomienda complementar este análisis con la evaluación de otros determinantes sociales y sanitarios para orientar una adecuada planificación de los recursos y contribuir a reducir las desigualdades en salud dentro de la provincia de Celendín.

4.3.12. PRIORIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

- **VIH:** fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico y seguimiento principalmente en Celendín y Cortegana, donde se concentra el 86,7% de los casos.

- **Tuberculosis:** fortalecer la detección, tratamiento y seguimiento, considerando especialmente la presencia de un caso de TB meníngea y uno pre-XDR.
- **Leishmaniasis:** priorizar Cortegana, Celendín, Huasmín y Chumuch por presentar el mayor número de casos.
- **EDA:** intensificar acciones de vigilancia y prevención en Cortegana, José Gálvez, Sucre y Chumuch, que presentan razones superiores al promedio provincial.
- **IRA:** fortalecer la vigilancia y prevención principalmente en Cortegana, Miguel Iglesias y Huasmín, por presentar las razones más elevadas.
- **Cáncer y diabetes:** fortalecer la detección temprana, seguimiento y continuidad de atención, considerando los 53 casos de cáncer y 243 casos de diabetes registrados en la provincia.
- **Vigilancia epidemiológica:** mejorar la oportunidad y calidad de la notificación, análisis territorial y utilización de la información para orientar las intervenciones sanitarias.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica – NOTIWEB, SIEPI-TB y registros de enfermedades no transmisibles, Red de Salud Celendín, 2025.
Elaboración: Oficina de Epidemiología, Red de Salud Celendín.

ANEXOS PLAN DE ACTIVIDADES